

URGENCIAS OTOLÓGICAS: OTALGIA

K.N. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia, J. Prada Pendolero.

OTALGIA

INTRODUCCIÓN

La otalgia es un síntoma muy frecuente. La innervación sensitiva del oído proviene de los pares craneales V, VII, IX, X y del plexo cervical (C2 y C3).

- Pabellón auricular: innervada por las ramas de los nervios craneales V, VII, X y ramas de los nervios cervicales C2 y C3.
- Conducto auditivo externo: nervios craneales V, VII y X par.
- Membrana timpánica: nervios craneales VII, IX y X par.
- Oído medio: nervios craneales V, VII y IX par.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa en su gran mayoría en una exhaustiva historia clínica y a veces se debe de confirmar con exámenes complementarios: analítica sanguínea, audiometría, impedanciometría, tomografía computarizada, resonancia magnética, otras.

La otalgia podemos dividirla en 2 grupos:

- **Otalgia primaria:** Originada en estructuras propias del oído como consecuencia de infecciones, traumatismos, cuerpos extraños, tapones de cerumen impactados, neoplasias otológicas y otros.
- **Otalgia secundaria:** Referida, por patología de estructuras vecinas: alteraciones dentales, disfunción de articulación temporomandibular, neuralgia del trigémino, neoplasias de cabeza y cuello, arteritis de la temporal, síndrome de Eagle.

características	Otalgia primaria	Otalgia secundaria
Dolor	Continuo y en aumento con los días	Intermitente asociado a patología de la ATM y con los movimientos de cavidad oral.
Síntomas	Otorrea, plenitud ótica, disminución de la audición.	fiebre, disfagia, reflujo gastroesofágico, dolor nasosinusales, odontalgias
Tiempo	Evolución corta	evolución larga

Manejo

Una historia clínica completa a veces es todo lo que se requiere para hacer un diagnóstico correcto y es esencial para determinar si la causa es primaria o secundaria.

Tiempo de evolución corto: sugiere una causa primaria o benigna.

Tiempo de evolución largo: sugiere una causa secundaria.

Preguntar presencia de otorrea, pérdida de audición, vértigo, plenitud auditiva y acúfenos. Buscar síntomas asociados con la cavidad oral, historia dental, síntomas orofaríngeos, antecedentes de amigdalitis y patología sinusal.

Exploración física: Inspección general del oído externo, regiones preauricular y postauricular, otoscopia y progresar hasta el examen de los pares craneales para evaluar si hay

complicaciones.

TRATAMIENTO

Dependerá del tipo de otalgia y en función a la clínica que presenta.

ALERTA

- Valoración por ORL si otalgia persistente o inexplicada con exploración normal; asociación de disfonía, disfagia, pérdida de peso; pérdida auditiva; inmunosuprimidos o diabéticos por progresión rápida de enfermedad. Por CMF si los síntomas parecen ser de origen odontogénico.

BIBLIOGRAFÍA

- Cummings C. Cummings otolaryngology head & neck surgery. Philadelphia, Pa: Elsevier Mosby. 2017.
- Poulton S, Yau S, Anderson D, Bennett D. Ear wax management. Aust Fam Physician 2015;44(10):731–34

URGENCIAS OTOLÓGICAS: PATOLOGÍA DEL OÍDO EXTERNO

K. N. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia, J. Prada Pendolero.

I. TRAUMATISMOS

Otohematoma

Introducción

Acúmulo de sangre en el espacio subpericóndrico del pabellón auricular, secundario a un traumatismo.

Diagnóstico

Inspección: Deformidad de pabellón auricular con pérdida de relieves.

Tratamiento En Urgencias

Drenaje de contenido bajo anestesia local previa asepsia:

- Punción y aspiración en pequeñas colecciones
- Incisión en el punto de mayor declive, extracción de coágulos y drenaje de Penrose con un punto de sutura no reabsorbible que se debe mantener durante 48 horas.

Vendaje compresivo que se adapte a la superficie del pabellón.

Profilaxis antibiótica antipseudomona: Ciprofloxacino 500mg VO cada 12 horas 7 días y revisión con especialista.



Otohematoma derecho

Heridas inciso-contusas

Introducción

Las heridas de pabellón auricular suelen ser secundarias a una acción mecánica. Pueden afectar piel, partes blandas, espesor de cartílago, con pérdida de sustancia, hasta arrancamiento de la oreja.

Diagnóstico

Inspección de toda la oreja, búsqueda de exposición de cartílago o hematomas asociados por traumatismos.

Tratamiento En Urgencias

- Lavado y desinfección
- Sutura de la herida con anestesia local. En caso de exposición o compromiso de cartílago, realizar la sutura solo de piel sin coger cartílago.
- Tratamiento antibiótico: Ciprofloxacino 500mg VO cada 12h 7 días (Principalmente en casos de afectación de cartílago).
- Si pérdida de sustancia o arrancamiento: Avisar a especialista

II. INFECCIONES

Pericondritis del pabellón

Introducción

Infección del pericondrio, secundario a traumatismos, heridas, quemaduras, otohematoma infectado, piercing. Agente etiológico: *Pseudomona aeruginosa*.

Diagnóstico

Oreja afectada eritematosa con inflamación de pabellón auricular, fiebre, calor y dolor local, pueden presentar absceso subpericóndricos y necrosis cartilaginosa.

Tratamiento En Urgencias

Antibioticoterapia antipseudomona: Ciprofloxacino. La vía de administración dependerá del grado de afectación y estado general del paciente. Solicitar valoración por especialista. ORL



Pericondritis

Herpes zoster ótico o Síndrome de Ramsay-Hunt

Introducción

Afectación del VII PC por el virus de la varicela zoster; por ello afecta la piel correspondiente al territorio sensitivo de n. facial (área de Ramsay-Hunt).

Diagnóstico

Dolor intenso tipo quemazón en oído y erupción eritematovesicular en piel de concha (vesículas propias del herpes), conducto auditivo externo, cara externa de membrana timpánica, mucosa de paladar. Si se asocia parálisis hemifacial ipsilateral al oído afectado, vértigo periférico e hipoacusia neurosensorial hablamos del síndrome de Ramsay-Hunt y es producto de la afectación añadida del VIII para craneal que progresa hasta el ganglio geniculado. Nos plantearemos en urgencias según la clínica que presente el paciente pruebas complementarias como:

- Analítica sanguínea: hemograma, coagulación básica, bioquímica con PCR
- TC Craneal.

Tratamiento

- Aciclovir 800mg cada 4 horas 7 días o Valaciclovir 1gr cada 8 horas 7 días.
- Corticoides orales: controvertido, siempre que se exista parálisis facial que puede ocurrir en el 50% de los casos.

Alerta

- Si asocia síntomas vestibulococleares (Hipoacusia/vértigo) requiere valoración por especialista. ORL



Herpes Zoster Ótico

Erisipela

Introducción

Lesiones en placa bien delimitadas, bordes sobre elevados, brillantes, induradas y dolorosas, pueden existir formas ampollosas. Suelen presentar edema, calor, hiperemia, fiebre, tiritonas (temblores), malestar general y adenopatías satélites. La etiología es:

Más frecuente: Estreptococo β -hemolíticos del grupo A.

Menos frecuente: Estreptococos del grupo G y C y Staphylococcus aureus (incluido el S. aureus meticilino resistente [MRSA]), Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, S. warneri, Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes, y especies de Moraxella.

Diagnóstico

Se basa en la clínica y el examen físico que presente.

Localización: casi siempre en cara y extremidades inferiores (Piernas). El MRSA es más frecuente en erisipelas de localización facial.

Erisipela localizada en cara se debe de realizar diagnóstico diferencial con herpes zóster, el angioedema y la dermatitis de contacto.

Si afecta al pabellón auricular hay que diferenciarlo de la pericondritis, en ésta última no existe afectación del lóbulo de la oreja mientras que en la erisipela se afecta todo el pabellón auricular

Tratamiento

Erisipela	ANTIBIÓTICO ELECCIÓN	ALTERNATIVO
Localización miembros inferiores	Penicilina V 500 mg v.o. cada 6h durante ≥ 2 semanas. Amoxicilina/Clavulánico (Augmentine 875/125mg) 1 comprimido v.o. cada 8 horas 10 días	
Formas graves	Penicilina G 1,2 millones de unidades IV cada 6 h, reemplazar por v.o. luego de 36 a 48 horas.	Ceftriaxona 1 g i.v. cada 24h. o Cefazolina 1 a 2 g i.v. cada 8 h.
Sospecha de infecciones estafilocócicas o MRSA o de localización facial.	Vancomicina 1 g i.v. cada 12 h. Dicloxacilina 500 mg v.o. cada 6 h durante 10 días.	Cloxacilina 500mg v.o. cada 6h x 10 días. Nafcilina 500mg v.o. cada 12 h x 7 días
Ante alergia penicilina	Eritromicina 500 mg v.o. cada 6 h durante 10 días	

i.v.: intravenoso; v.o.: vía oral.

OTITIS

Es un proceso infeccioso o inflamatorio del oído.

Otitis externas

Patología infecciosa de la piel del conducto auditivo externo (CAE). Puede ser infeccioso, dermatológico o alérgico.

Clasificación.

- Según forma de inicio: agudas o crónicas.
- Según su extensión: difusas o localizadas.
- Según la zona de origen: primarias o secundarias.
- Según los agentes causantes: bacterianas, fúngicas, virales y mixtas.

Clínica.

Los síntomas más frecuentes son: el dolor, picor, hipoacusia y la sensación de cuerpo extraño en el oído.

Otitis externa difusa

Introducción

Típica De Verano, Por Baño En Mar O Piscinas Con Agua Contaminada Secundario A Traumatismo Por Autolimpieza Con Bastoncillos Higiénicos, Dermatitis Eccematosa. Germen Causal: Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Bacilos Gram Negativos Y Ocasionalmente Hongos.

Diagnóstico

Clínica: Otagia, otorrea, hipoacusia transmisiva. Hacer diagnóstico diferencial con otitis media aguda supurada, si observamos membrana timpánica normal o ligeramente hiperémica confirmamos otitis externa, si membrana timpánica abombado, perforado con otorrea confirmamos que se trata de otitis media aguda supurada, ante la duda diagnóstica o dificultad de visualizar membrana timpánica usar antibiótico sistémicos y gotas locales.

Exploración con otoscopio: Edema variable del CAE, otorrea purulenta. Signo del trago positivo. El CAE se aprecia congestivo, eritematoso, gran intensidad de dolor al tacto, se aprecia una inflamación del CAE en toda su trayectoria con grados variables de estenosis, edema y otorrea que dificulta la visualización del tímpano.

Tratamiento

- Limpieza del CAE: se limpiara con portaalgodones o aspirador, si obstrucción completa del CAE o abundante otorrea avisar a ORL.
- Gotas óticas: Combinación de corticosteroides y antibiotico (Colircusi gentadexa aplicar 3-4 gotas cada 8 horas 7 días o Cetraxal (ciprofloxacino) plus aplicar 3-4 gotas cada 12 horas 7 días u ofloxacino 0,3% gotas 3-5 gotas cada 12h durante 7 días). Otras combinaciones como neomicina, polimixina e hidrocortisona; ciprofloxacino y mometasona; gentamicina y dexametasona.
- Amoxicilina-clavulanico 875/125mg 1 cada 8h durante 7 días o ceftibuteno 400mg c/8h durante 7 días o ciprofloxacino oral 500mg cada 12 horas 7 días. Se debe de añadir antibiótico oral si el paciente esta inmunodeprimido, diabetes mellitus y tiene afectado el CAE con gran edema o celulitis periorbitaria.
- Revisión por ORL preferente dentro de las 48h.
- No mojar el oído, calor seco local.
- Analgésicos y antiinflamatorios vía oral: ibuprofeno 600mg 1 cada 8h durante 3 días.



Otitis externa difusa

Otitis externa localizada o circunscrita

Introducción

Se caracteriza por presencia de un forúnculo en la piel del CAE. Germen causal: Staphylococcus aureus. Tras traumatismo o inmunidad disminuida.

Diagnóstico

Se basa fundamentalmente en una rigurosa historia clínica.

Clínica: Otagia.

Exploración: otoscopia: tumefacción eritematosa circunscrita.

Tratamiento

- Si el absceso no está maduro, no realizar ninguna acción local agresiva.
- Si absceso maduro: Avisar a especialista para drenaje
- Mupirocina en pomada aplicar de forma tópica sobre la lesión 2 veces al día.
- Cloxacilina 500mg cada 8 horas 7 días/ Amoxicilina-Ac. Clavulánico 875/125mg 1 comprimido cada 8 horas 7 días.
- Analgésicos antiinflamatorios.

Otitis externa maligna

Introducción

Es una infección crónica del oído por *Pseudomonas aeruginosa*. Forma grave de otitis externa, que afecta fundamentalmente a la población inmunodeprimida, ancianos o con diabetes mellitus. Puede producir necrosis de partes blandas y osteítis. Agente causal: *Pseudomona aeruginosa*.

Diagnóstico

- **Clínica:** Otorrea fétida, otalgia lancinante. Es una infección que se caracteriza por una otorrea crónica seropurulenta, verdosa, resistente al tratamiento médico habitual, se acompaña frecuentemente de parálisis facial periférica.
- **Otoscoopia:** Esfacelos y restos necróticos de piel, tejido de granulación o polipoides. Leucocitosis con neutrofilia, VSG y proteína C reactiva elevadas.

Actitud en urgencias.

- Constantes vitales.
- Analítica sanguínea: hemograma, bioquímica básica con PCR y coagulación (si toma de anticoagulantes).
- Cultivo de secreción de oído.
- TAC craneal: oído medio y del hueso mastoides del temporal (se puede observar destrucción ósea del peñasco).
- Interconsulta a ORL de guardia.

Tratamiento

- Tratamiento de elección es ciprofloxacino 500mg 1 cada 12h durante 10 días vía oral asociado con ofloxacino tópico o norfloxacino tópico.

- **¡Importante!** Interconsulta a ORL para valoración del tratamiento intravenoso por importante riesgo de osteomielitis basocerebral.

Miringitis bullosa u otitis gripal

Introducción

Causa importante de otalgia y a veces de otorrea sero-hemática, de inicio brusco y se produce al inicio de cuadro agudo viral, a la exploración se aprecia una o varias bullas serosas o hemorrágicas que se localizan sobre la membrana timpánica y a veces sobre la piel del conducto auditivo externo óseo, produciendo infección de la piel del CAE y capa externa de tímpano por virus influenzae o parainfluenza.

Diagnóstico

Otalgia intensa en contexto gripal con otorragia u otorrea serosanguinolenta. Otoscopia: Ampollas o bullas serosas, hemorrágicas violáceas sobre la piel del tímpano.

Tratamiento

- Sintomático. A base de gotas óticas que contengan anestésico y corticoides, tener presente la posibilidad de que evolucione a una otitis media aguda en 1 ó 2 días por lo que es recomendable controlar al paciente en 2 ó 3 días.
- Analgésicos vía oral.
- Calor local en periodo agudo.

Otomycosis

Introducción

Infección fúngica de piel de CAE. Agentes causales más habituales son los hongos del género *Aspergillus*, *Cándida*. Predisponentes: traumatismo, tratamientos antibióticos previos.

Diagnóstico

Prurito ótico, otalgia, hipoacusia con sensación de taponamiento ótico. A la Otoscopia se observa masa fúngica que ocupa CAE, puede ser de color marrón-negruzco (*Aspergillus*) o algodonoso (*Candida Albicans*). Secreción pastosa con hifas negruzcas o blanquecinas.

Tratamiento

Si presenta abundante contenido en CAE, avisar a especialista para aspiración y limpieza previa a la aplicación de tratamiento tópico.

Gotas óticas, alternativas:

- Alcohol boricado a saturación aplicar 4 gotas cada 12 horas 7 días
- Menaderm otológico 2-3 gotas cada 8 horas 7 días
- Canesten solución 2-3 gotas cada 8-12 horas

Revisión por ORL.

III. CUERPOS EXTRAÑOS

Introducción

Tres tipos:

- Animales: Insectos
- Vegetales: Semillas
- Inanimados: Tapones de silicona

Diagnóstico

Otoscopia

Tratamiento

- **Extracción.** En el caso de insectos, aplicar en el oído unas gotas de **alcohol o anestésico** antes de la extracción. La mayoría se puede extraer con irrigación de agua templada en una jeringa con cierta presión (EXCEPTO SI EXISTE PERFORACIÓN TIMPÁNICA CONOCIDA).
- **Avisar a ORL:** Si dificultad en la extracción, o duda en la integridad de la membrana timpánica.

BIBLIOGRAFÍA

- Perez Delgado L, Herrera Tolosana S, Fraile Rodrigo JJ. Traumatismos del oído. Heridas. Conmoción laberíntica. Fracturas del hueso temporal. Secuelas. Libro virtual en formación

ORL 22:1-2.

- Basterra Alegría J, Campos Catalá A. Enfermedades del oído externo. Tratado de otorrinolaringología y patología cervicofacial. España: Elsevier; 2009.p.73-81
- Revista Médica Clínica Las Condes. OTALGIA, DOLOR EN EL OÍDO. Vol. 27. Núm. 6. Tema central: Otología. Páginas 892-897 (Noviembre 2016. <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-otalgia-dolor-en-el-oido-S0716864016301249>

PATOLOGÍAS DEL OÍDO MEDIO

K.N. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia, J. Prada Pendolero.

OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)

Introducción

Patología frecuente, precedida de historia de cuadro catarral o infección de vías respiratorias altas previas, principal causa de otalgia en los niños, se presenta a cualquier edad, pero es más frecuente en niños entre los 3 meses y los 3 años debido a que la trompa auditiva es inmadura tanto estructural como funcional. Germen: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella Catarrhalis.



Otitis media aguda

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico, tiene un inicio abrupto y reciente de otalgia con hipoacusia transmisiva y sensación de plenitud. Según la evolución del cuadro existen 2 presentaciones otoscópicas:

- Membrana timpánica abombada y eritematosa sin otorrea (OTALGIA INTENSA POR DISTENSIÓN TIMPÁNICA).
- Perforación timpánica reciente, con otorrea serosanguinolenta (OTALGIA DE MENOR INTENSIDAD).

En general en la otoscopia se aprecia membrana timpánica muy enrojecida o abombada, clínicamente puede presentar otalgia/otodinia intensa, hipoacusia, acúfenos, fiebre y malestar general. Si hay perforación timpánica sin complicaciones la resolución de la perforación timpánica suele ser espontánea y completa en pocas semanas. Si no se resuelve la perforación timpánica estaremos frente a una OTITIS MEDIA CRÓNICA, pudiendo ser:

Simple: perforación simple, central con fondo de mucosa de la caja sano.

Colesteatomatosa: perforación marginal, normalmente posterosuperior con fondo de mucosa de la caja con presencia de escamas blancas o granulaciones. Es ambos casos (simple o colestomatosa) el tratamiento requiere cirugía programada: miringoplastia (forma simple) y timpanoplastia (forma colestomatosa).

Tratamiento

- **Antibiótico:**

- Amoxicilina 500mg – 1g: 1c/cada 8h durante 7 días.
- Amoxicilina Clavulánico 875/125mg: 1cada 8 horas durante 7 días.
- Cefuroxima (Zinnat, Nivador o Selan) 500mg cada 12h durante 6 días.
- Si alergia a penicilina: Claritromicina (Klacid, Bremon) 500mg 1 cada 12h durante 10 días o Azitromicina 500mg cada 24 horas 3 días.
- Si otorrea: añadir gotas óticas: colircusi gentadexa 3-4 gotas cada 8 horas 7 días o Cetraxal plus 3-4 gotas cada 12 horas 7 días.

- **AINES:**

Dexketoprofeno 25mg 1 cada 8h durante 5 días o

Ibuprofeno 600mg 1 cada 8h durante 5 días.

NOTA: Descartar Complicaciones. AVISAR A ORL!

- MASTOIDITIS: edema con borramiento de surco retroauricular o fluctuación por absceso. “Urgencia médico-quirúrgica”
- LABERINTITIS: OMA asociada a vértigo de características periféricas.
- PARÁLISIS FACIAL.
- MENINGITIS: OMA + clínica neurológica

Bibliografía

- Cummings C. Cummings otolaryngology head & neck surgery. Philadelphia, Pa: Elsevier Mosby. 2017.
- Lorenzo Monasta, Luca Ronfani, Federico Marchetti, Marcella Montico, Liza Vecchi Brumatti, Alessandro Bavcar Burden of Disease Caused by Otitis Media: Systematic Review and Global Estimates PLoS One., 7 (2012), pp. e36226.

PATOLOGÍA TRAUMÁTICA DEL OÍDO

K.N. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia, J. Prada Pendolero.

BLAST AURICULAR

Introducción

Traumatismo auricular por onda expansiva (blast) se debe a un aumento repentino de la presión en el conducto auditivo externo (CAE). Son lesiones traumáticas sobre el oído medio por cambios **súbitos** de presión. Estallido de materiales explosivos hasta una bofetada, pasando por impactos de objetos (bolas de nieve, balones).

Diagnóstico

¡Historia clínica! Exploración variable, desde otoscopia normal, hemotímpano hasta perforaciones timpánicas irregulares con puntos hemorrágicos; puede haber daño de la cadena osicular y mareo.

Tratamiento En Urgencias

Analgesia y AINES.

Gotas óticas si perforación.

Seguimiento por ORL.

BAROTRAUMA

Introducción

Alteraciones del oído medio por cambios **progresivos** de presión no compensados por trompa de Eustaquio (viajes aéreos, submarinismo o descensos rápidos de puertos y montañas).

Diagnóstico

Sensación de plenitud ótica, otalgia intensa, acúfenos, autofonía e hipoacusia de transmisión. Otoscopia: desde normal hasta perforación timpánica.

Tratamiento

Analgesia y AINES.

Pauta corta de corticoides orales.

Seguimiento por ORL.

FRACTURAS DE HUESO TEMPORAL

Introducción

Lesiones causadas en contexto de TCE.

Diagnóstico

¡Primero descartar patología neuroquirúrgica con prueba de imagen! TAC Craneal.

Otoscopia: hemotímpano o perforación. Las de trazo transversales pueden presentar vértigo o cofosis y parálisis facial; las longitudinales (más frecuentes) suele cursar con otorragia. La mayoría son mixtas.

Tratamiento En Urgencias

Valoración por ORL

PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA

K.N. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia, J. Prada Pendolero.

Introducción

Parálisis flácida de toda la musculatura hemifacial como consecuencia de una lesión en el trayecto periférico del **nervio facial o séptimo par craneal**. Lo más importante es descartar que sea una parálisis de causa central.

Causas: Idiopática (parálisis de Bell), infecciosa (Síndrome de Ramsay Hunt), traumática.

Diagnóstico

- **NOTA:** Realizar exploración neurológica general.

- **Parálisis facial central:** lesión a nivel supranuclear. Parálisis hemifacial completa con afectación frontal ipsilateral.
- **Parálisis facial periférica:** afectación hemifacial que conserva la función motora frontal.

Exploración general ORL: otoscopia y búsqueda de vesículas en el CAE (Ramsay-Hunt) o si hay patología colesteatomatosa. Si otoscopia normal, solicitar valoración por ORL. Acumetría. Exploración neurológica: estructurada.

Diferencia entre parálisis facial periférica y parálisis facial central

Parálisis facial periférica	Parálisis facial central
• Asimetría facial, dificultad para elevar la ceja y cerrar el ojo • Signo de Bell positivo • Comisura bucal desviada hacia el lado sano. • Alteración de los sentidos y otalgia	• Musculatura conservada de la frente y párpado superior • Signo de Bell negativo

Causas principales de parálisis facial periférica y central

Parálisis facial periférica	Parálisis facial central
• Idiopática o parálisis de Bell, síndrome de Ramsay-Hunt, esclerosis múltiple, mononucleosis, fractura del hueso temporal (peñasco) y basicraneales, cirugía de oído, otitis media, herpes simple tipo 1 (VHS-1), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).	• ACV, infecciones, tumores.

Clínica: Es común (parálisis de Bell): Instauración brusca con aplanamiento de pliegue nasolabial, caída de comisura bucal, puede existir antecedente de cuadro vírico. Signo de Bell. Disgeusia o Algiacusia.

Valorar según Escala de House-Brackman

GRADO I: Normal	Normal
GRADO II: Leve	Asimetría bucal
GRADO III: Moderado	Cierre ocular con mínimo esfuerzo
GRADO IV: Moderado-severo	Cierre ocupar con esfuerzo máximo
GRADO V: Severo	Cierre de ojos incompleto (Signo de Bell)
GRADO VI: Total	Ningún movimiento

Pruebas complementarias.

- Hemograma.
- Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, amilasa, PCR.
- Coagulación básica.
- TAC craneal: si sospecha de parálisis facial no idiopática o patología neurológica acompañante.

Tratamiento

- Prednisona 1mg kg/día pauta descendente durante 1 mes.
- Si Herpes: Añadir Aciclovir 800 mg cada 4h durante 7 días (omitir dosis nocturna) o Famciclovir (Famvir) 500 mg cada 8h durante 7 días o Valtrex (valaciclovir) 500 mg cada 12h 7 días.
- Lagrimas artificiales a demanda
- Protección ocular (Parche por las noches).
- Seguimiento por ORL.

Bibliografía

- J. Valls-Solé Facial palsy, postparalytic facial syndrome, and hemifacial spasm Move Disord, 17Suppl (2002), pp. 49-52
- T.L. Yen,C.L.W. Driscoll,A.K. Lalwani Significance of House-Brackmann facial nerve grading global score of differential facial nerve function Otol Neurology, 24 (2003), pp. 118-122

HIPOACUSIA BRUSCA

K.N. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia, J. Prada Pendolero.

Introducción

Pérdida auditiva neurosensorial superior a 30dB en 3 o más frecuencias consecutivas, en un tiempo de instauración inferior a las 72 horas. Etiología desconocida, teoría viral.

Diagnóstico

Otoscopia normal. Acumetría: Rinne positivo, Weber lateralizado al oído sano.

Ante estos hallazgos valoración por ORL.

Tratamiento

Tratar a todos los pacientes diagnosticados en los primeros 45 días tras el inicio del episodio.

- Prednisona o metilprednisolona oral empezando con 1mg/kg peso descendiendo pauta cada 5 días hasta completar ciclo de 25 días.
- Audiometría tonal de control a la semana, al mes y al año.
- Controles con ORL

Bibliografía

- Mettrailer AM, Babu SC. Management of sudden sensorineural hearing loss. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2016; 24: 403-6
- García Berrocal JR, García Arumí A, Herrera M, Lavilla MJ, Amarillo E, Del Toro L, Plaza G. 2º Consenso sobre diagnóstico y tratamiento de la sordera súbita (SS) en España. 2016.

VÉRTIGO PERIFÉRICO EN URGENCIAS

M. Tucciarone, P. Pinacho Martínez, González-Orús Álvarez-Morujo R.

¡RECUERDA!

- La base del abordaje del vértigo en urgencias son la HISTORIA CLÍNICA y la EXPLORACIÓN FÍSICA.
- La prioridad en todo momento debe ser DESCARTAR ORIGEN CENTRAL.

Introducción

El vértigo es la sensación ilusoria de movimiento del entorno o del propio cuerpo que no se asocia a pérdida de consciencia. Puede ser de naturaleza central o periférica (lo más frecuente).

El vértigo y el mareo son síntomas muy frecuentemente referidos por los pacientes en urgencias; en ocasiones el diagnóstico puede ser muy complejo y por esto es esencial dominar su diagnóstico diferencial.

Existen numerosas entidades clínicas que pueden cursar con vértigo periférico. Sin embargo, el manejo en urgencias tiene que mirar esencialmente a diferenciarlo de los vértigos de causa central.

En este capítulo nos centraremos en el abordaje del síndrome vestibular agudo (SVA).

El SVA es un cuadro de mareo con sensación intensa de giro de objetos o del propio cuerpo, de aparición brusca, que se acompaña de náuseas o vómitos, inestabilidad para la marcha, nistagmo e intolerancia a los movimientos cefálicos, con una duración de 24 horas o más. En general el SVA aparece de manera aislada (con o sin hipoacusia); su principal causa es periférica (neuritis vestibular o laberintitis), pero lo fundamental es saber diferenciarlo de las causas centrales. Siempre se ha dado mucha importancia a las pruebas de imagen, siendo el TC cerebral la prueba más utilizada en urgencias para estos pacientes; sin embargo esta prueba presenta una baja sensibilidad en el diagnóstico del infarto agudo que disminuye a menos del 20% si nos referimos a infartos de fosa posterior. Una prueba más sensible sería la RMN que solo tiene una tasa de falsos negativos de aproximadamente el 12 %, aunque en las urgencias generalmente no se dispone de esta prueba.

Una correcta exploración otoneurológica es lo más importante para el manejo de un SVA en urgencias, y debido a esto presentamos un protocolo estandarizado útil en el diagnóstico diferencial¹.

Protocolo HINTS + standing

(Head-Impulse, Nystagmus, Test of Skew)

- **Maniobra de impulso cefálico (HIT):** exploración de la integridad del reflejo vestíbulo-ocular (VOR) realizando giros rápidos de la cabeza del paciente, con angulación de 20grados mientras el mismo fija la nariz del explorador; en déficits vestibulares severos suele ser positiva (97-100%). Un HIT negativo en un SVA tiene que hacer sospechar una causa central.
- **Nistagmo espontáneo:** la presencia de un nistagmo evocado por la mirada (cambio de dirección del nistagmo según cambio en la mirada) es altamente sugestivo de patología cerebelosa y troncoencefálica.
- **Skew test (cover test):** se realiza una oclusión ocular alternante y se observan los movimientos correctivos del ojo descubierto en el plano vertical; si el signo es positivo es

sugestivo de patología central.

- **Standing:** en los pacientes que no sean capaces de levantarse y deambular sin ayuda se sospechará un vértigo central².

Diagnóstico

El diagnóstico del vértigo periférico es esencialmente clínico, basado en una buena anamnesis y una detallada exploración³. De forma muy esquemática vamos a clasificar en función de la repetición de los episodios de vértigos y en función de la asociación con hipoacusia.

CRISIS ÚNICA	CRISIS RECURRENTES
CON HIPOACUSIA • Con afectación coclear (laberintitis) • Neuritis cocleovestibular (Sd. Ramsay Hunt)	CON HIPOACUSIA • Enfermedad de Ménière • Migraña tipo basilar • Enfermedad autoinmunitaria de oído interno • Neurosífilis-otosífilis • Fístula perilinfática
SIN HIPOACUSIA • Neuritis vestibular	SIN HIPOACUSIA PROVOCADAS: • VPPB: por la postura • Fístula perilinfática: por la presión ESPONTANEAS: • Migraña vestibular • vértigo paroxístico de la infancia

Patología	Antecedentes	Causa	Inicio	Duración	Nistagmo
Neuritis vestibular	-proceso viral	-reactivación VSH 1 - vascular	- brusco	Horas al día	Localizador
VPPB	- TCE - cirugía de oído - neuritis vestibular - espontanea	-canalitis -cupololitis	- movimientos cefálicos	<1 minuto	Localizador
E. de Ménière	- crisis recurrentes	-Hydrops endolinfático	- síntomas otológicos (hipoacusia acúfenos, plenitud ótica...)	20 minutos/horas	No localizador
Fístula perilinfática	- TCE - Cirugía de oído - espontanea	- comunicación anómala entre oído medio e interno	- Valsalva, aumento presión en CAE, ruidos intensos (CSS)	Minutos/horas	Localizador

Tratamiento

El tratamiento del SVA es fundamentalmente sintomático: consiste en tratamiento antiemético y con sedantes vestibulares en la fase aguda, máximo 3-4 días, para no impedir la aparición de la compensación central del déficit vestibular, y en el tratamiento de soporte con fluidoterapia para la posible deshidratación/ desnutrición acompañante.

En el caso del VPPB, el especialista ORL se encargará de realizar las específicas maniobras de reposición.

Después de la resolución en urgencias del SVA el ORL se encargará del seguimiento periódico de los pacientes en las consultas.

Fármaco	Dosis	Precauciones
Diazepam	VO: 2.5-10mg/6-12h IV: 5-10mg/8-12h	Glaucoma, adicción, embarazo, sedación
Clonazepam	VO: 0,5mg/8h	Idem
Tietilperacina	VO: 5.10mg/8h SC: 10mg/8h	Enf. Hepática, No usar con benzodiacepinas
Metoclopramida	VO: 5-10mg/24h IM IV: 10mg/4-6h	Enf hepática o renal, obstrucción inestinal, feocromocitoma
Ondasentron	VO: 8mg/12h	
Sulpirida	VO: 50mg/8h IM: 100mg/12h	

VO: Vía Oral. IM: Intra Muscular. IV: Intra Venoso.

Bibliografía

- Kattah JC, Talkad AV, Wang DZ, Hsieh YH. HINTS to diagnose stroke in the acute vestibular síndrome: three-step bedside oculomotor examination more sensitive than early MRI diffusion-weighted imaging. Stroke. 2009 Nov; 40(11): 3504-10.
- Vanni S, Pecci R, Casati C, Moroni F, Risso M, Ottaviani M, Nazerian P, Grifoni S, Vannucchi P. STANDING, a four step bedside algorithm for differential diagnosis of acute vértigo in the Emergency Department. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2014 Dec; 34(6): 419-26.
- Soto-Varela A, Aran-González I, López-Escámez JA et al. Peripheral vértigo classification of the otoneurology Committee of the Spanish Otorhinolaryngology Society: diagnostic agreement and update (versión 2-2011). Acta Otorrinolaringol Esp 2012 Mar-Apr; 63 (2): 125-31.

URGENCIAS NASOSINUSALES

N. Bilbao Garitagoitia, K. Montaña Rueda, J. Prada Pendolero.

FRACTURA NASAL

Es una de las fracturas faciales más frecuentes y pueden presentar implicaciones estéticas y funcionales.

Contusión Nasal

No laterorrinia ni alteraciones en la palpación.

Tratamiento: hielo local y analgesia

Fractura Nasal

Laterorrinia, crepitación, hundimiento. Posible pérdida de sustancia o exposición de cartílago.

La Rx de huesos propios. NO suele ser definitiva.

Tratamiento: Derivar a ORL para reducción.

Cubrir con ciprofloxacino si cartílago expuesto.

Si gran edema que dificulta la exploración, pautar antiinflamatorio local y sistémico y reevaluar en 1 ó 2 días.

Si **hematoma septal**: clínica de obstrucción nasal y punta de nariz dolorosa.

Tratamiento: derivar a ORL, es necesario el drenaje.

Nota

- La radiografía de huesos propios tiene más valor médico-legal que clínico. La decisión quirúrgica se basa en la exploración, la edad y la situación general del paciente. Descartar hematoma septal.



Fractura de huesos propios

URGENCIAS NASOSINUSALES

N. Bilbao Garitagoitia, K. Montaña Rueda, J. Prada Pendolero.

CUERPO EXTRAÑOS INTRANASALES

Introducción

Afección muy frecuente sobre todo en niños de entre 1 y 4 años. Naturaleza variable: piedras, juguetes, organismos vegetales...etc. Importante diagnóstico y tratamiento precoz para evitar complicaciones. Clínica frecuente de rinorrea mucopurulenta o sanguinolenta unilateral. Debemos tener especial cuidado con las pilas ya que tienen riesgo de producir en pocas horas daño en mucosa por decúbito, lesiones cáusticas y quemaduras químicas (electrolisis y producción de hidróxido de potasio).

Se suelen encontrar generalmente en la zona anterior (meato inferior, entre tabique y cornete medio), pero se debe tener cuidado con los que penetran hasta vía posterior ya que existe riesgo de aspiración si el cuerpo extraño cae por la nasofaringe.

Diagnóstico:

- Clínica de rinorrea purulenta unilateral, con posible edema y eritema de dorso nasal. Halitosis, rinolalia, cefalea, insuficiencia nasal respiratoria.
- Se realizará **rinoscopia anterior**, puede ser de ayuda aspirar secreciones con cuidado de no empujar el cuerpo extraño o también la colocación de mechas con anestesia tópica y vasoconstrictor para una mejor exploración.
- **Radiografía simple de senos paranasales y cavum** si sospecha de cuerpo extraño radiopaco o
- **TAC y fibrolaringoscopia** si fuese necesario.
- Es posible que pasen desapercibidos durante mucho tiempo según la naturaleza de su origen. Pueden originar úlceras y posterior necrosis osteocartilaginosa cuando se trata de componente reactivos (pilas)
- Son infrecuentes las complicaciones graves como la celulitis facial.

Tratamiento

- En pacientes pediátricos, inmovilizar al paciente y realizar extracción mediante técnica adecuada,.
- Utilizar un gancho romo y aspiración, realizando la extracción de dentro a fuera o mediante succión. Nunca empujar el cuerpo extraño hacia posterior. Riesgo de aspiración.
- Tras la extracción realizar lavados nasales en domicilio y seguimiento si precisa.

No realizar intentos repetidos; derivar a ORL para valoración y extracción con cirugía endoscópica y anestesia general si fuese preciso.

Nota

- Importante realizar extracción del cuerpo extraño de forma temprana y con instrumental adecuado. El personal debe conocer la técnica, ya que corremos el riesgo de introducirlo más profundamente y producir aspiración del cuerpo extraño.

Bibliografía

- Chacón Martínez J, Morales Puebla J.M, Padilla Parrado M. Capítulo 50. Epistaxis y cuerpos extraños nasales. Libro virtual de formación de ORL.

- Gicquel P, Fontanel JP. Cuerpos extraños de las fosas nasales. Rinolitiasis. En: Encycl Méd Chir Oto-rhino-laryngologie. Paris: Elsevier; 20-390-A-10, 1995: 1-5
- Artigas-Sapiain C, Sarriá-Echegaray P, Tomás-Barberán M. Manejo de cuerpos extraños nasales y óticos en niños. Semergen. 2010;36(5):278–282.
- Eisele D, McQuone S. Emergencies of the Head and Neck. Editorial Mosby; 2000.
- Cummings otolaryngology–head & neck surgery. 6th ed. Philadelphia: Saunders; 2015.

URGENCIAS NASOSINUSALES

N. Bilbao Garitagoitia, K. Montaña Rueda, J. Prada Pendolero.

EPISTAXIS

Introducción

Todo sangrado originado en las fosas nasales es una epistaxis, más frecuente en hombres, es fácilmente controlable pero a veces puede comprometer la vida por hemorragias intensas. Se estima que más del 90% de las epistaxis provienen del área de Kiesselbach. Aun así, la irrigación nasal se lleva a cabo por ramas de la arteria carótida interna y externa por lo que puede generar grandes sangrados posteriores. Es la urgencia más frecuente de ORL por la que acuden a urgencias, debido en gran medida a una gran vascularización de las fosas nasales, la distribución submucosa de sus vasos y la débil protección y la superficialidad de las fosas y pirámide nasales.

Causas

Es diversa su etiología: epistaxis esencial (es la más frecuente), traumática (traumatismos maxilofaciales, otros), infecciones e inflamaciones (rinitis), resequedad de la mucosa (aire seco), cuerpos extraños en fosas nasales (asociado a olor y rinorrea fétida), causas sistémicas como la HTA, alteración de la coagulación, factores hormonales como tumores hormono secretores: feocromocitoma, neoplasia naso-sinusal u otras, etc.

Locales	Sistémicas
• Traumatismos: nasales, craneales. • Cuerpo extraño (rinorrea fétida) • Infecciones: resfriado común. • Rinitis/sinusitis. • factores hormonales como tumores hormono secretores: feocromocitoma. • Tumores: hemangioma, angiofibroma juvenil.	• Hipertensión arterial. • Alteración de la coagulación por consumo de fármacos como los anticoagulantes, AINES, AAS. • Enfermedades hematológicas: von Willebrand, Bernard-Soulier, Werlhof (PTI), Rendu-Weber Osler.

Clasificación. Según su localización se clasifica en:

- **Epistaxis anterior:** el punto de sangrado se localiza en la zona anterior de las fosas nasales generalmente en el área de Kiesselbach ubicados en la parte anterior del tabique nasal o en su proximidad, es la forma más frecuente en niños y adultos, la sangre sale por la fosa nasal anterior.
- **Epistaxis posterior:** se origina en las ramas posterolaterales de la arteria esfenopalatinas y arterias etmoidales, sangran hacia la faringe por las coanas, expulsa la sangre por la boca, obligándonos a plantear un diagnóstico diferencial con la hematemesis o hemoptisis.
- **Epistaxis difusa**

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico, basado en la presencia y expulsión de sangre por las fosas nasales (epistaxis anterior) o por la boca (epistaxis posterior), debemos de:

- Valorar causas desencadenantes y antecedente de traumatismo, cirugía previa, cuerpo extraño, antecedentes previos, etc.
- Anamnesis detallada: tratamiento habitual, antecedente de HTA, anticoagulantes, antiagregantes, enfermedades hematológicas, drogas intranasales.

Tratamiento

- **Medidas generales en urgencias.**

1. Constantes vitales y canalización de vía venosa periférica.
2. Estabilización hemodinámica si el sangrado es abundante y sospecha de hipovolemia.
3. Control de HTA si tensión alta.
4. Analítica sanguínea (si sangrado abundante o toma de anticoagulantes): hemograma, bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, alaninoamino transferasa (ALT o GPT), aspartato aminotransferasa (AST o GOT), bilirrubina, PCR. y coagulación.

- **Taponamiento anterior:**

Considera usar medidas generales de protección individual: guantes, mascarilla facial o lentes de protección y bata. Los sangrados anteriores podrán ser localizados con vasoconstrictor tópico (lidocaína 2% o adrenalina 1/1,000) y cauterizados con stick de nitrato de plata, electrocauterio o criocauterio.

- Paciente sentado con la cabeza levantada, tranquilice y explíquele el procedimiento a realizar.
- Limpiar con suero fisiológico las fosas nasales.
- Humedecer un algodón con oximetazolina o lidocaína 2% o adrenalina 1/1000 introducirlo en la fosa nasal sangrante y comprimir con los dedos por ambos lados de las alas nasales durante un tiempo mínimo de 10 a 15 minutos. Habitualmente con este procedimiento debería de parar el sangrado.
- Pida que abra la boca y observe la pared posterior de la faringe, si observa que fluye sangre a pesar de la oclusión nasal podría dar a entender que el sangrado procede de la parte posterior de la nariz: epistaxis posterior.
- El taponamiento anterior se realiza con Merocel, la gasa de borde, Rapid Rhino.
- Mantener durante 2 días si sangrado es leve excepto en los que reaparece el sangrado tras retirar el taponamiento en ese caso se retira entre 4 y 7 días (pacientes con sangrado más intenso, toma de anticoagulantes o presentan coagulopatías) y se administra cobertura antibiótica.*
- Si sangrado no se controla con taponamiento anterior se avisar a ORL.

- **Taponamiento posterior.**

Indicada cuando falla el taponamiento anterior, la epistaxis es muy posterior.

1. Previo al procedimiento considera usar medidas generales de protección: guantes, mascarilla facial o lentes de protección y bata.
2. Anestesiarse la fosa nasal sangrante con lidocaína 2% más adrenalina 1:1,000
3. Se realiza neumotaponamiento con sonda bibalonada, introducir la sonda por la fosa nasal sangrante, el **balón distal** se llena con 10ml de suero fisiológico, traccionar suavemente hasta sentir resistencia y se hincha en el cavum. El **balón proximal** se llena con 30 ml de suero fisiológico, se hincha en la fosa nasal quedando ocluida con el fin de cohibir el sangrado. El taponamiento se retira en 4 días. Se debe de administrar cobertura antibiótica.*

Si el taponamiento anterior y el posterior no detienen el sangrado se debe de avisar al ORL de guardia, para que valore el mejor tratamiento oportuno y/o otras técnicas invasivas como:

Embolización arterial (menos usada, alta efectividad, punto sangrante se localiza mediante arteriografía) o

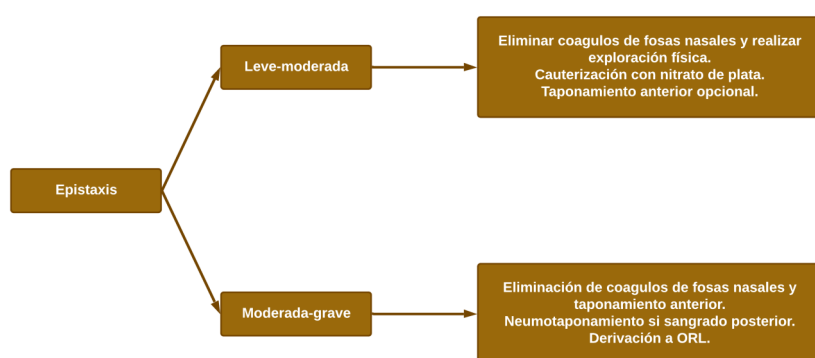
Ligaduras arteriales (según el punto sangrante puede ligarse una o varias arterias: la maxilar interna, la arteria etmoidal anterior, la arteria esfenopalatina) mediante cirugía endoscopia nasosinusal (CENS).

- **Cobertura antibiótica:**

Amoxicilina / ácido clavulánico 875/125mg cada 8h x 7 días ó

Clindamicina 300mg cada 12h x 8 días ó

Trimetoprima/sulfametoxazol 160/800mg 1 cada 12h x 7 días.



Bibliografía

- Beck, R., Sorge, M., Schneider, A., & Dietz, A. (2018). Current Approaches to Epistaxis Treatment in Primary and Secondary Care. *Deutsches Arzteblatt international*, 115(1-02), 12–22.
- Fatakia, A., Winters, R., & Amedee, R. G. (2010). Epistaxis: a common problem. *The Ochsner journal*, 10(3), 176–178.
- Smith, J., Hanson, J., Chowdhury, R., & Bungard, T. J. (2019). Community-based management of epistaxis: Who bloody knows?. *Canadian pharmacists journal : CPJ = Revue des pharmaciens du Canada : RPC*, 152(3), 164–176.
- Pinilla Urraca M. Tratamiento de la epistaxis en Atención Primaria. *Form Act Pediatr Aten Prim*. 2014;7;94-101
- Kontos J. Actualización: Epistaxis. *Evidencia-Actualización en la Práctica Ambulatoria*. 2007;10(4):115-7.
- Handbook of Otolaryngology. Head and Neck Surgery. 2011: 597-599. David Goldenberg. Bradley J. Goldstein
- Rhinology and Endoscopic Sinus Surgery. Cummings otolaryngology–head & neck surgery. 6th ed. Philadelphia: Saunders; 2015.
- Pinilla Urraca M. Tratamiento de la epistaxis en Atención Primaria. 2014, vol. 7, nº 2

URGENCIAS NASOSINUSALES

N. Bilbao Garitagoitia, K. Montaña Rueda, J. Prada Pendolero.

RINOSINUSITIS

Introducción

La rinosinusitis (RS) es la inflamación sintomática de la mucosa de las fosas nasales y senos paranasales, se caracteriza por presentar los siguientes síntomas (dos o más): obstrucción o congestión nasal, hiposmia o anosmia, rinorrea anterior o posterior, sensación de presión facial o dolor. Se puede asociar **signos endoscópicos** (presencia de pólipos, rinorrea mucopurulenta en meato medio y edema de la mucosa del meato medio) y/o **alteraciones en TAC de senos paranasales** (cambios en ostiomeatal y/o en la mucosa de los senos). Se clasifica:

Según el seno afectado en: etmoidales, maxilares, frontales y esfenoidales.

Según el tiempo de evolución pueden ser:

- **Aguda:** si la duración de los síntomas es inferior a 12 semanas, sus síntomas desaparecen de forma completa. El origen puede ser **vírico (resfriado común)**: los síntomas pueden durar 10 - 15 días. **Bacteriano:** Los síntomas empeoran a los 5 días o persisten 10 -15 días.
- **Crónica:** si la duración de los síntomas es mayor de 12 semanas y no desaparecen y pueden empeorar de forma transitoria.
- **Recurrente:** si se presenta tres o más episodios agudos al año

Diagnóstico

Se basa en la clínica, fundamentalmente en la anamnesis y la exploración clínica con rinoscopia, preferible endoscopia. No son necesarias las pruebas de imagen complementarias a menos que:

- Se sospeche complicación, a pesar de haber recibido tratamiento adecuado y la evolución es desfavorable.
- Presente afectación sistémica o estemos frente a paciente con inmunodepresión, en estos caso deberá de solicitarse:
- TC de senos paranasales.
- La Rx simple de senos paranasales tiene alto índice de falsos positivos y negativos.

SINUSITIS AGUDA

Introducción

Inflamación de la mucosa de uno o más senos paranasales. Los senos maxilares son los que con más frecuencia se afectan. El resfriado común es la causa más frecuente que provoca la inflamación de la mucosa y la obstrucción del drenaje de los senos. También existen otras causas como: rinitis alérgica, los pólipos nasales, las alteraciones anatómicas, los tumores, los traumatismos, el exceso de uso de descongestionantes nasales e inmunodeficiencias sistémicas y locales.

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico. Presenta clínica de obstrucción nasal, secreción bilateral, presión o algia facial, fiebre.

Viral: síntomas durante menos de 10 días y sin empeoramiento de la clínica.

Bacteriano: síntomas persistentes durante más de 10 días o persistentes con empeoramiento.

Rinoscopia anterior: mucosa edematosa y secreciones purulentas. Palpación de puntos sinusales.

Tratamiento

RSA: tratamiento sintomático con analgésicos, corticoides intranasales a 2 pulverizaciones en cada fosa nasal 1 ó 2 veces al día e irrigación con agua salina diaria.

RSBA: sin complicaciones, elegir entre tratamiento sintomático (siempre que haya seguimiento en 7 días) o tratamiento sintomático más antibiótico (Amoxicilina con o sin Ácido clavulánico c/8h durante 5-10 días). Si es alérgico a penicilina se puede usar las quinolonas como: Levofloxacino, moxifloxacino. Si persisten los síntomas en 7 días, añadir otro antibiótico o cambio de línea. Cefalosporinas de 2ª generación: cefuroxima o cefpodoxima.

Si paciente con infección severa con mala respuesta al tratamiento inicial, con sospecha o presencia de complicaciones usar cefalosporina 3ª generación vía parenteral: ceftriaxona IV o cefotaxima IV asociado a vancomicina. Si se sospecha de sinusitis odontógena asociar ATB frente a anaerobios: asociar amoxilina y metronidazol. La duración del tratamiento deberá ser entre 10 - 14 días y por lo general mantener el ATB 7 días después de obtener mejoría clínica.

SINUSITIS CRÓNICA

Introducción

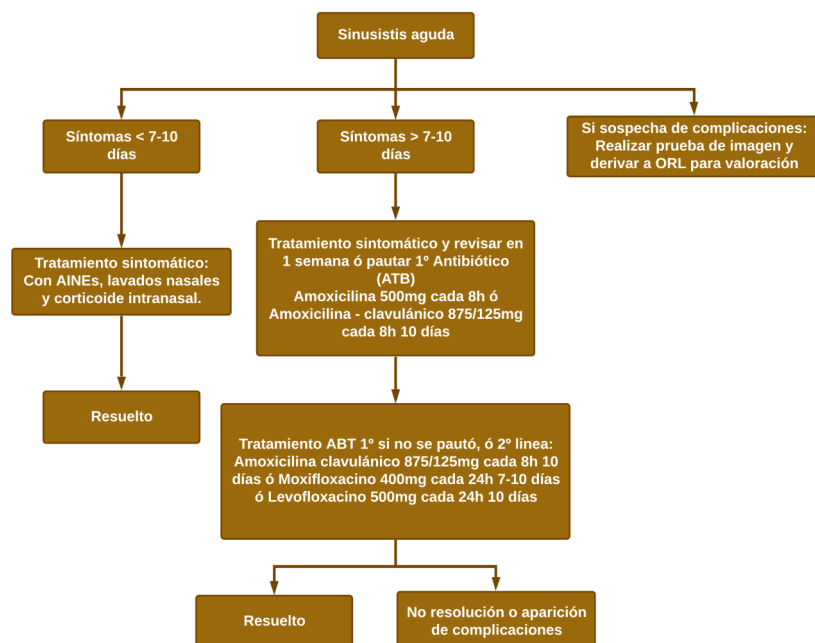
Síntomas durante más de 12 semanas, objetivados mediante exploración con rinoscopia anterior, endoscopia y tomografía axial computarizada.

Diagnóstico

Actitud en urgencias: solicitar seguimiento por consulta de ORL.

Nota

- En ningún caso el diagnóstico de sinusitis se fundamentará en una imagen radiológica alterada.



COMPLICACIONES DE LA SINUSITIS

Introducción

Son poco frecuentes, no superan el 5% de los casos. Siempre derivar a ORL.

Las complicaciones pueden ser locales, orbitarias e intracraneales. Siendo las orbitarias y las intracraneales las más frecuentes.

1. Complicaciones locales

Mucoceles que dependiendo del seno afectado generarán diferentes síntomas.

2. Complicaciones orbitarias (3%)

Necesitan una atención inmediata. Más frecuente en inmunosuprimidos. 5 grados según la clasificación de Chandler:

Grado	Descripción
I	Celulitis preseptal
II	Celulitis orbitaria
III	Absceso subperióstico
IV	Absceso orbitario
V	Trombosis séptica del seno cavernoso

Diagnóstico

- anamnesis, exploración ORL y Oftalmológica.
- Edema periorbitario, proptosis y fiebre. Después diplopía, disminución de agudeza visual, oftalmoplegia...
- Pruebas de imagen: TAC de elección.

Tratamiento

- Antibioticoterapia intravenosa (IV): cefalosporinas de 3º generación: ceftriaxona 2 gr IV.

3. Complicaciones intracraneales (<1%).

Introducción

Meningitis, osteomielitis, trombosis del seno dural, absceso intracraneal, abscesos epidurales, subdurales y cerebrales. Son emergencias fatales.

Diagnóstico

Es clínico fundamentalmente.

- Examen físico completo con valoración de pares craneales y estado neurológico.
- Analítica sanguínea: hemograma, bioquímica básica con PCR, coagulación.
- Punción lumbar.
- TAC Craneal.

Tratamiento

Antibioticoterapia empírica IV a altas dosis según hallazgos de punción lumbar, generalmente ceftriaxona o cefepima, con posible cobertura añadida con vancomicina. Valorar drenaje.

BIBLIOGRAFÍA

- Del Cuvillo A, Soto JG. Rinitis y rinosinusitis, “rasgos tratables” del asma. Rev Asma. 2018;3(2):55-69.
- Libro Virtual de Formación en Otorrinolaringología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Capítulo 102. Madrid. 2015.
- Suárez Nieto C, Gil-Carcedo García L.M, Marco Algarra J, Medina J. E, Ortega del Álamo P, Trinidad Pinedo J. Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Edición 2, Editorial Panamericana. Año 2009.
- Shah K, Stanley Shapshay R, “Acute laryngitis” Emedicine; Web MD, 2006
- Cobeta Marco, I. Otorrinolaringología y patología cervicofacial. Ars Médica, 2003

URGENCIAS NASOSINUSALES

POLIPOSIS NASOSINUSAL

Introducción

Es una forma de rinosinusitis crónica.

Diagnóstico

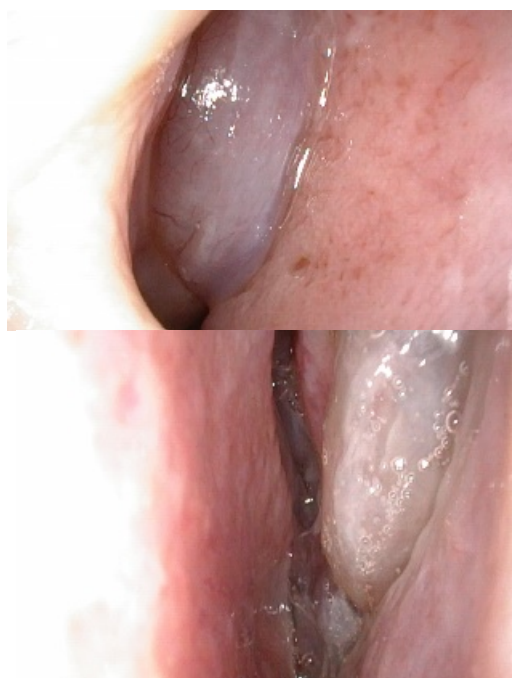
- 2 o más síntomas de los siguientes: obstrucción nasal bilateral, secreción nasal anterior o posterior, dolor o presión facial e hipo o anosmia.
- Exploración: pólipos nasales en ambas fosas, rinorrea anterior o posterior

Tratamiento En Urgencias

Corticoides tópicos intranasales 2 pulverizaciones en cada fosa nasal cada 24h.

Nota

- Derivar al paciente a consulta de ORL para valoración y seguimiento.



Poliposis nasosinusal

URGENCIAS NASOSINUSALES

RINOSINUSITIS AGUDA FÚNGICA INVASIVA

N. Bilbao Garitagoitia, K. Montaña Rueda, J. Prada Pendolero.

INTRODUCCIÓN

Es una enfermedad grave, de curso agudo y frecuentemente mortal. Se caracteriza por una infiltración fungica progresiva de la submucosa y vasos sanguíneos de la cavidad nasal y paranasal. El cornete medio es la zona más frecuente de invasión fungica. Conocida también como **mucormicosis rinocerebral**, es una enfermedad rápidamente agresiva y fulminante.

Factores de riesgo. La enfermedad ocurre principalmente en pacientes inmunocomprometidos como:

- Diabetes mellitus mal controlados.
- Neoplasias malignas hematológicas.
- uso prolongado de glucocorticoides.
- Pacientes VIH/SIDA.
- Otros factores: insuficiencia renal o hepática, trasplante de órganos sólidos y enfermedades autoinmunes. La neutropenia severa (recuento absoluto de neutrófilos menor de 500 células/mL) es un factor predisponente.

Organismos más frecuentes: Mucor o Aspergillus species. Es necesaria una alta sospecha.

DIAGNÓSTICO

Para el diagnóstico es necesario tener una alta sospecha clínica y se confirma con pruebas complementarias.

- Evaluación urgente, con enfoque en pares craneales y endoscopia nasal.
- Síntomas como epistaxis, congestión/obstrucción nasal, secreciones purulentas, cefalea, algia facial, alteraciones visuales.
- Una escara negra intranasal en el examen físico es patognomónico de Mucor invasivo. Serán necesarias las biopsias para el diagnóstico.
- Interconsulta a ORL.

Pruebas complementarias en urgencias

- Hemograma completo con recuento y fórmula leucocitaria.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, alanina aminotransferasa (ALT o GPT), aspartato aminotransferasa (AST o GOT), LDH, amilasa, bilirrubina, PCR, procalcitonina.
- Coagulación.
- TC de senos paranasales.
- RM para valorar extensión.

TRATAMIENTO

- **Anfotericina B** en dosis de 0,25-1,0 mg/kg/día, hasta un total de 2-4 gramos en 6 a 8 semanas. Dado su toxicidad nefrotóxica, se recomienda el uso de anfotericina liposomal en dosis de 3-5 mg/kg/día en caso de constatarse una creatinemia superior a 2,5 mg/dL o ante evidencia de progresión de enfermedad con dosis máxima de terapia estándar.
- **Voriconazol: en Pseudallescheria boydii o Aspergillus:** se usan dosis superiores debido a

su mayor resistencia, conlleva un riesgo mayor de nefrotoxicidad. El tratamiento de elección es el **voriconazol**: dosis habitual en adultos es de 6 mg/kg vía endovenosa 2 veces al día durante el primer día, posteriormente 4 mg/kg 2 veces al día por 7 días, con eventual traslape a terapia oral con 200 mg 2 veces al día. Es importante considerar que este esquema es solo válido para estas excepciones, dada la baja actividad del voriconazol en la división **Zygomycota**.

- **Debridamiento quirúrgico:** es una emergencia quirúrgica. Es necesaria una resección quirúrgica completa de los tejidos.

Nota

- Es una emergencia quirúrgica. Importante sospecharla en pacientes inmunodeprimidos.

BIBLIOGRAFÍA

- Penna M, Barahona L, Ruz P, Valdés C. Rinosinusitis fúngica invasiva aguda: Actualización en pacientes adultos y pediátricos. Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Vol.79 N°.3. Santiago. Set. 2019.

URGENCIAS NASOSINUSALES

VESTIBULITIS BACTERIANA

N. Bilbao Garitagoitia, K. Montaña Rueda, J. Prada Pendolero.

Introducción

Infección de partes blandas en zona de vestíbulo nasal. Secundario a rinorrea constante, infecciones virales o microtraumatismo continuo.

La forunculosis nasal: es resultado de infecciones por *Staphylococcus Aureus* de los folículos pilosos.

Clínica de dolor en región de punta nasal, eritema, aumento de volumen de partes blandas e induración. Posible edema circundante y fiebre.



Vestibulitis

Diagnóstico

- Anamnesis y exploración física

Tratamiento En Urgencias

- Antibiótico oral con cloxacilina
- Tratamiento tópico con pomadas como las que contienen sulfato de neomicina o mupirocina.

Nota

- No se recomienda manipulación de la zona ni de las lesiones debido a que el sistema venoso de la punta nasal drena en el seno cavernoso y existe riesgo de diseminación infecciosa.

BIBLIOGRAFÍA

- Handbook of Otolaryngology. Head and Neck Surgery. 2011: 597-599. David Goldenberg. Bradley J. Goldstein
- Clinical practice guideline (Update): adult sinusitis. American Academy Of Otolaryngology-Head And Neck Surgery. 2015, Vol 152(2S) S 1 – S39
- Cummings otolaryngology-head & neck surgery. 6th ed. Philadelphia: Saunders; 2015.

URGENCIAS FARINGOLARÍNGEAS

J. Prada Pendolero, K. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia.

SEMIOLOGÍA FARÍNGEA:

- Dolor faríngeo
 - Espontáneo
 - Con la deglución
 - Con la masticación
- Disfagia
 - Aguda o progresiva
 - Total o parcial
 - Sólidos y/o líquidos
- Trismus
- Sialorrea

URGENCIAS FARINGOLARÍNGEAS

SEMIOLOGÍA LARÍNGEA:

- Disfonía (Aguda/Crónica)
- Disnea (Aguda/Progresiva)
- Estridor
 - Inspiratorio (Glótico/supraglótico)
 - Espiratorio (Bronquial)
 - Mixto (Subglótico/traqueal)

URGENCIAS FARINGOLARÍNGEAS

FARINGOAMIGDALITIS AGUDA

J. Prada Pendolero, K. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia.

FARINGOAMIGDALITIS AGUDA

Bacteriana

Introducción

Agente causal: Streptococo b hemolítico Grupo A

Clínica:

- Inicio brusco
- Odinofagia, fiebre y MEG
- Ausencia de tos y rinorrea

Exploración:

- Hipertrofia de amígdalas con exudado purulento
- Adenopatías yugulodigástricas bilaterales dolorosas
- Leucocitosis con neutrofilia

Diagnóstico

Clínico + cultivo SHBA + (70%)

Tratamiento En Urgencias

Penicilinas V oral o Benzatina IM. Amoxicilina-clavulánico o cefalosporina. Alérgicos: eritromicina/claritromicina o clindamicina.

Vírica

Introducción

Agente causal: adenovirus, rinovirus

Diagnóstico

Clínica:

- Más frecuente
- Epidemia de comunidad (primavera/verano)
- Odinofagia sin MEG. Acompaña síntomas catarrales

Exploración:

- Eritema en orofaringe sin exudado pultáceo
- No adenopatías
- Linfocitosis/linfopenia

Tratamiento

Reposo y sintomático.

Esquema de tratamiento de las faringoamigdalitis

	Tratamiento	Alternativas	Otros tratamientos

Faringoamigdalitis aguda	Penicilina Amoxicilina Amoxicilina-ácido clavulánico Cefalosporinas orales ¹	Azitromicina Claritromicina	Clindamicina
Faringoamigdalitis recurrente	Amoxicilina-ácido clavulánico		Cirugía
Todas las faringoamigdalitis en que los betalactámicos no sean adecuados	Miocamicina Azitromicina Claritromicina		

CONSENSO FARINGOAMIGDALITIS (2003)*

Amigdalitis específicas

1. ANGINA DE PAUL-VINCENT

Introducción

A la exploración orofaríngea se aprecia una angina ulcerada cubierta de una membrana amarillenta, se asocia a lesiones en cavidad oral y encías como gingivitis y pericoronaritis.

- Agente causal: Bacterias fusospirales (*Borrelia Vincentii*) producida por la infección conjunta por *Fusobacterium* y *Treponema microdentium*.
- Angina unilateral ulceronecrótica irregular
- Afecta adultos jóvenes con mala higiene bucal

Clínica:

- Astenia+ aliento fétido+ adenopatía cervical dolorosa
- Puede producir Síndrome Lemierre

Exploración: amigdalitis unilateral, olor fétido, boca séptica

Diagnóstico

Muestra faríngea + exploración

Tratamiento

- Penicilina G o V, amoxicilina-clavulánico o cefuroxima
- Analgesicos tipo paracetamol y AINEs tipo ibuprofeno.
- Avisar a ORL

2. ANGINA DE LUDWIG

Introducción.

Es una infección de los tejidos blandos del cuello y piso de la lengua, colección purulenta debajo de la lengua, entre el músculo milohioides y el plano cutáneo del suelo de la boca. Afecta la vía aérea por su avance rápido y silencioso, puede llegar a ser mortal. Es rara y poco frecuente.

Principales factores que contribuyen en su origen desde deficiente higiene dental, extracción de piezas dentales, infecciones de encías, infecciones por piercing linguales hasta pacientes inmunocomprometidos.

Es una infección polimicrobiana desde flora normal y otros: anaerobios, *Streptococcus viridans*, *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Fusobacterium* y *Bacteroides*.

Origen: dental o de mandíbula, la infección se inicia en la parte inferior de la boca, generalmente en el segundo o tercer molar de la mandíbula, se propaga rápidamente a estructuras sublinguales y submandibulares.

Diagnóstico.

Es clínico y se confirma con pruebas complementarias:

- Hemograma, bioquímica con PCR / Procalcitonina y coagulación
- TC craneal/facial/cuello.

Clínica característica: eritema submandibular, induración y edema, dolor, fiebre, dificultad para la deglución y cerrar la boca, malestar general, rigidez de cuello, babeo, ronquera y disnea por edema de laringe. Si hay estridor y cianosis son signos de mal pronóstico. En la exploración física: se observa en orofaríngea una tumoración en el suelo de la boca con edema de la lengua.

Tratamiento.

Medidas generales en urgencias.

- Constantes vitales, canalizar vía venosa periférica.
- Asegurar vía aérea con oxigenoterapia según corresponda desde gafas nasales, ventimax con reservorio hasta traqueostomía de emergencia.
- Suero terapia, analgesia, AINES.
- Antibioticoterapia: Penicilina G sódica más metronidazol o clindamicina (cubrir anaerobios).

Medidas específicas.

- Avisar a ORL.
- Drenaje quirúrgico.
- Ingreso

3. HERPANGINA

Introducción

Afecta con mayor frecuencia a lactantes y niños 1 - 7 años . La enfermedad deja inmunidad persistente, pero puede presentar nuevos episodios por otros coxsackievirus A u otros enterovirus.

Agente causal: enterovirus, coxsackie grupo A.

Clínica: se caracteriza por aparición súbita de Fiebre alta + odinofagia+ úlceras o vesículas en pilar anterior amigdalár, paladar blando, las amígdalas, la úvula o la lengua



Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la clínica: los síntomas y las lesiones características en boca.

Tratamiento

Sintomático e higiene bucal adecuada.

4. SÍNDROME MANO-BOCA-PIE.**Introducción**

Coxsackie A., enterovirus u otros enterovirus.

Clínica: La infección produce una erupción vesiculosa en la mucosa y la piel. Faringitis vesiculosa + erupción palmas y plantas.

Diagnóstico.

Es clínico.

Tratamiento.

Sintomático.

Nota

- No afecta cavidad bucal

5. DIFTERIA**Introducción**

Corynebacterium diphtheriae

Clínica: fiebre+debilidad+ malestar+disfagia

Exploración física: Pseudomembrana blanquecina que NO desprende y que cubre, amígdalas, úvula pilares y velo. (Inicio habitualmente en amígdala)

Puede causar problemas obstructivos



Diagnóstico

Cultivo faringoamigdalino

Tratamiento

- Penicilina/eritromicina y toxoide diftérico
- Si sospecha alta: antitoxina diftérica

Prevención: Vacuna (tétanos+ difteria+ tos ferina)

Nota

- Aumento de casos por la disminución de la vacunación y la inmigración.

Bibliografía

- Libro Virtual de Formación en Otorrinolaringología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. 2015.
- Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, 2ª Edición. Carlos Suárez Nieto et al.
- Dorothy S. Carlson, Ellen Pfadt. Angina de Vincent y angina de Ludwig: dos infecciones orales peligrosas. Nursing 2011, mayo 21 : <https://www.elsevier.es/es-revista-nursing-20-articulo-angina-vincent-angina-ludwig-dos-0212538211702291>

URGENCIAS FARINGOLARÍNGEAS

ABSCESOS CERVICALES

J. Prada Pendolero, K. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia.

A. Flemón /absceso periamigdalino

Introducción

Absceso/flemón entre amígdala y músculo constrictor superior. Complicación más frecuente de la amigdalitis bacteriana.

Típico adultos jóvenes.

Clínica: Fiebre+ odinofagia intensa + otalgia refleja + mal aliento+ voz engolada

Exploración: TRISMUS + abombamiento de pilar amigdalino y desplazamiento de úvula lado contralateral.



Diagnóstico

- Clínico+ punción positiva con salida de pus (absceso)

Tratamiento Urgencias

- AVISAR A ORL
- Antibiótico intravenoso + corticoides intravenoso (amoxicilina/clavulánico 1gr/8h o Clindamicina 300-600 mg/6h) + drenaje quirúrgico intraoral.

Nota

- Criterio de amigdalectomía de forma diferida.

B. Angina ludwig

Introducción

Polibacteriana. Infección suelo de la boca. En paciente con mala higiene oral o manipulación dental.

Clínica: Dolor cervical, voz engolada dificultad respiratoria

Exploración: Inflamación región submentoniana+ déficit de movilidad lingual+ protusión lingual

Diagnóstico

Clínica+ exploración+ TAC Cervical

Tratamiento Urgencias

Ingreso hospitalario.

Vigilancia estrecha. Antibiótico intravenoso: (amoxicilina/clavulánico 1 g/8h o clindamicina 600

mg/6 h o Meropenem 1g/8h) + corticoides intravenoso (mg/kg /24h)

Riesgo de complicación vía aérea

Avisar ORL

Nota

- Puede aparecer disnea brusca y necesidad de manejo de vía aérea urgente

Absceso retrofaringeo

Introducción

Infección de los ganglios retrofaringeos. Típico de niños.

Clínica: Fiebre +adenopatías+ odinofagia+ alteración en voz

Exploración: fluctuación pared faríngea posterior.



Diagnóstico

Clínica+ Rx lateral cervical

Tratamiento

- Antibiótico intravenoso: (amoxicilina-clavulánico 1g/8 h o Meropenem 1 gr/ 8h). Alérgicos: Clindamicina 600 mg/6 h o Metronidazol 500mg/8h + Gentamicina
- Puede requerir drenaje intra o extraoral
- Avisar ORL

Absceso parafaríngeo

Introducción

Absceso entre músculo constrictor superior y vaina vascular carotídea.

Riesgo de Síndrome Lemierre.

Exploración: MEG+ dolor cervical+ odinofagia



Diagnóstico

Clínico+ TAC cervical

Tratamiento

Antibiótico iv (Amoxicilina-clavulánico 1g/8 h o Meropenem 1 gr/ 8h). Alérgicos: Clindamicina 600 mg/6 h + Gentamicina

Puede requerir drenaje cervical

AVISAR ORL

Nota

- Control estrecho del paciente. Control hemodinámico. Riesgo elevado de mediastinitis y sepsis. Valorar criterios de UCI.

Bibliografía

- Page C, Biet A, Zaatar R, Strunski V. Parapharyngeal abscesses: diagnosis and treatment. Eur ArcOtorhinolaryngol 2008;265(6):681-6
- Plaza Mayor G, Martínez San-Millán JM, Martínez Vidal A. Is a conservative treatment of Deep neck space infections appropriate? Head and Neck 2001;23(2):126-33
- Guía de Práctica Clínica. Diagnóstico y tratamiento de los abscesos profundos del cuello, México; Instituto Mexicano del Seguro Social, 2009

URGENCIAS FARINGOLARÍNGEAS

MONONUCLEOSIS

INFECCIOSAS

J. Prada Pendolero, K. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia.

Introducción

Es una enfermedad producida por el Virus Epstein Barr, afecta principalmente en la primera infancia, adolescencia o adultos jóvenes.

Existen otros agentes que causan Síndrome Mononucleósido

Clínica y exploración.

TRIADA: fiebre + amigdalitis + poliadenopatías (cervicales anteriores y posteriores, inguinales y axilares). En la amigdalitis se aprecia exudado pultáceo extenso, similar a la faringitis estreptocócica. Se puede observar petequias en la confluencia del paladar duro con el blando. Los síntomas remiten en aproximadamente en 2-4 semanas.

- Fiebre: intensidad variable
- Angina: exudado blanquecino grisáceo que se desprende (pseudomembranosa). Se acompaña de petequias en paladar blando.
- Adenopatías +++. Típicos triángulos posteriores cervicales y axilar e inguinal.
- Hepatoesplenomegalia, ictericia. Astenia

Diagnóstico

- Hemograma: linfomonocitosis. Linfocitos atípicos. Transaminasas +++
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT (transaminasa glutámico-oxalacética), GPT (glutamato-piruvato transaminasa), Gamma-glutamyl-transferasa (GGT o Gama GT), Lactato deshidrogenasa (LDH), Amilasa, bilirruina, PCR.
- Tes de Paul-Bunnell: positivo
- Serología de virus de Epstein-Barr (VEB): positivo

Exantema con amoxicilina

Tratamiento

Reposo, analgesia, antitérmicos e hidratación

Evitar traumatismos abdominales (riesgo de ruptura bazo)

Corticoides: si hemólisis, lesiones neurológicas o hepáticas

20 % sobreinfección bacteriana. Uso de clindamicina 300 mg/8 h durante 7 días oral.

Nota

- Seriación de transaminasas de forma ambulatoria posteriormente.

Bibliografía

- Luzuriaga K, Sullivan JL. Infectious mononucleosis. N Engl J Med 2010; 362:1993.
- Odumade OA, Hogquist KA, Balfour HH Jr. Progress and problems in understanding and

managing primary Epstein-Barr virus infections. Clin Microbiol Rev 2011; 24:193.

URGENCIAS FARINGOLARÍNGEAS

EPIGLOTITIS

J. Prada Pendolero, K. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia.

Introducción

Agente causal: *Haemophilus influenzae* tipo B.

Clínica: Babeo+ estridor + incorporación de paciente hacia delante+ fiebre.

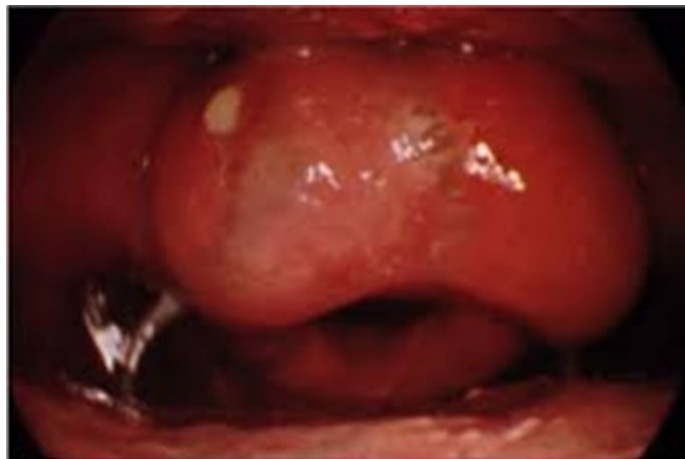
Exploración: sialorrea+ Rx de partes blandas cervicales

Diagnóstico

Clínico

Tratamiento

- Antibiótico iv (amoxicilina/clavulánico o cefalosporinas)+ Corticoides iv
- Riesgo de traqueotomía
- Monitorización. Cabecero incorporado. Dieta absoluta.
- Avisar ORL



Nota

- Evitar manipulaciones o exploraciones agresivas. Evitar disnea aguda.

URGENCIAS FARINGOLARÍNGEAS

LARINGITIS AGUDAS

J. Prada Pendolero, K. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia.

Infecciosas

Introducción:

Causa más frecuente de disfonía aguda. En edad pediátrica cuadros de laringotraqueítis/crup laríngeo con mayor afectación subglótico. De predominio en invierno. Puede aparecer tras esfuerzo o abuso vocal importante.

Agente implicado: virus respiratorios (adenovirus, myxovirus). Algunas entidades con microorganismos específicos (mycoplasma, difteria, TBC, hongos,...)

Clínica: disfonía acompañada de odinofagia, tos y febrícula.

Exploración: no adenopatías cervicales. Faringoscopia poco llamativa.

Laringoscopia indirecta/ fibrolaringoscopia: eritema de ambas cuerdas vocales.

Diagnóstico

Clínico

Tratamiento En Urgencias

- Reposo vocal
- Gargarismos
- Abundante hidratación
- Ambiente húmedo y aerosoles.
- Antiinflamatorio habitual (Ibuprofeno 600 mg/8 h o Dexketoprofeno 25 mg/8h durante 4-5 días)
- Ciclo corto de corticoides orales (prednisona)

No Infecciosas

Introducción

Existen diferentes tipos (alérgicas, térmicas, traumáticas, por reflujo y por cáusticos). Vigilar los inhalantes en pacientes con patología pulmonar.

Clínica: disfonía. Picor faringolaríngeo. Carraspera.

Exploración: irritación laríngea.

Diagnóstico

Sospecha clínica

Tratamiento

Medidas higiénicas, reposo vocal, hidratación. Con sospecha de signos indirecto de ERGE, pautar IBP (Omeprazol 20 mg/24 horas 6 semanas).

Nota

- Ante una disfonía de más de 3 semanas de evolución. Derivar a consultas externas de ORL

Bibliografía

- Shah K, Stanley Shapshay R, "Acute laryngitis" Emedicine; Web MD, 2006
- Libro Virtual de Formación en Otorrinolaringología de la Sociedad Española de

Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Capítulo 102.Madrid. 2015.

URGENCIAS FARINGOLARÍNGEAS

CUERPOS EXTRAÑOS

FARÍNGEOS

R. Gómez-Blasi Camacho, L. López Flórez, C. Martín Oviedo.

- Importancia de la historia para establecer el grado de sospecha y la localización
- Las radiografías de rutina no están indicadas

Introducción

La ingestión de un cuerpo extraño es una patología que con frecuencia se considera banal por el paciente, pero que ocasionalmente puede dar lugar a complicaciones que comprometan la vida del mismo. Es una situación que encontraremos a menudo en las urgencias, y que, dependiendo de su localización, puede ser resuelta o no sin necesidad de especialistas. Es fundamental establecer el grado de sospecha para distinguir entre posibles cuerpos extraños, que debemos buscar con energía y otras sensaciones más crónicas y difusas que podemos estudiar de forma ambulatoria.

Son frecuentes en los niños, tanto de forma voluntaria como involuntaria, donde puede ser difícil su diagnóstico y lo sospecharemos mediante la anamnesis. En la mayoría de adultos, por otra parte, se trata de un hecho accidental que nos indican ellos mismos. El tratamiento consiste en su extracción, requiriendo en ocasiones anestesia general en función de la localización, nivel de impactación y edad del paciente (1).

Diagnóstico

Historia Clínica

En primer lugar debemos interrogar al paciente sobre la intensidad, calidad y tiempo de evolución de su sensación. Un cuerpo extraño suele producir una sensación aguda, bien definida y con un origen concreto, normalmente coincidiendo con una comida. Una molestia más crónica, con un origen difuso, es poco probable que se deba a un cuerpo extraño.

Pediremos que se señale “a punta de dedo” donde nota la sensación. Los cuerpos extraños suelen producir un dolor bien localizado, punzante y que aumenta con la deglución. Si la zona es más difusa y es descrita como una molestia en lugar de como dolor, es menos probable que la cause un cuerpo extraño.

La localización es importante también de cara al manejo. Si señala la zona del ángulo de la mandíbula, probablemente se encuentre clavado en las amígdalas o la base de lengua. Si señala la zona de la nuez, estará en la epiglotis, senos piriformes o la boca de Killian y necesitaremos hacer una laringoscopia indirecta o fibroscopia para verlo y extraerlo. Si señala el esternón, se tratará de un cuerpo extraño esofágico.

Debemos prestar atención a algunos síntomas acompañantes. Afagia y sialorrea sugieren impactación esofágica. La disfagia puede aparecer con cuerpos extraños en hipofaringe, pero más frecuentemente se encontrarán en esófago. Si el paciente presenta disnea o estridor, avisaremos a ORL.

La naturaleza del cuerpo extraño también es algo a considerar. Lo más frecuente es encontrarnos con espinas de pescado y huesos de otros animales, como pollo o conejo. Otros cuerpos

extraños, como verduras o plásticos, aunque pueden producir molestias, es más difícil que permanezcan en la orofaringe o hipofaringe. Por otra parte, las impactaciones esofágicas suelen estar causadas por bolos cárnicos.

Exploración

Primero hacemos una exploración orofaríngea. Pediremos al paciente que mantenga la lengua dentro de la boca y la relaje, mientras nosotros la presionamos con uno o dos depresores. Buscaremos en las amígdalas, los pilares amigdalinos, la orofaringe y la base de la lengua. Para explorar esta última zona, nos ayudará colocarnos algo por encima del paciente y presionar con firmeza la lengua. Aun así, para explorarla en su totalidad, es necesario hacer una laringoscopia indirecta. Es importante no confundir el caseum amigdalor o tonsilolitos con cuerpos extraños.

Podemos utilizar la palpación para ayudarnos en la exploración: con un dedo tocaremos la base de lengua, amígdalas y las paredes de la faringe. Puede que notemos nosotros mismo el cuerpo extraño, o más frecuentemente, que al palpar determinada zona el paciente indique que ahí nota un pinchazo. Esto nos ayudará a determinar su localización.

Para explorar la hipofaringe, epiglotis y glotis, también hay que hacer una laringoscopia indirecta o una fibroscopia. Si no encontramos el cuerpo extraño en la exploración orofaríngea y tenemos sospecha de que éste existe, llamaremos al especialista ORL para que las realice. Si hay sospecha de impactación esofágica, avisaremos al especialista en Digestivo para valorar una endoscopia.

Si la sospecha es baja podemos dar de alta al paciente con tratamiento antiinflamatorio durante 2 o 3 días, advirtiéndole que acuda de nuevo si aparece algún síntoma de alarma: fiebre, tortícolis, dolor o inflamación cervical. Si la sensación persiste, derivaremos al paciente a consultas ORL para una exploración faríngea completa de manera reglada.

Salvo que sospechemos un cuerpo extraño metálico, la radiografía simple tiene una baja sensibilidad, por lo que no debe pedirse de entrada (2) (3). El uso del bario como contraste mejora la sensibilidad de ésta, pero complica una eventual endoscopia, por lo que se desaconseja. Si hay sospecha de perforación esofágica se debe pedir TC.

Tratamiento en urgencias

Si encontramos el cuerpo extraño en las amígdalas o la orofaringe, lo extraeremos con unas pinzas. El reflejo nauseoso puede dificultarnos la tarea. Para reprimirlo es útil indicar al paciente que respire solo por la boca, con respiraciones largas y continuas y también utilizar anestésicos tópicos. Si encontramos la espina en la base de la lengua, también podremos retirarla mediante unas pinzas largas, como las de bayoneta. Deprimiremos con firmeza la lengua y deslizaremos sobre ella las pinzas hasta llegar a la base.

Si el cuerpo extraño se encuentra más abajo, será el ORL quien lo extraiga mediante laringoscopia indirecta y pinzas curvas o con fibroscopio con canal de trabajo. En ocasiones no es posible y es necesario retirarlo con un laringoscopio rígido, bajo sedación o anestesia general.

Al retirar el cuerpo extraño debe desaparecer o reducirse mucho el dolor. Si persisten algunas molestias pueden ser tratadas con antiinflamatorios. Después de la retirada, si no hay complicaciones, el paciente puede ser dado de alta.



Bibliografía

- Merino Gálvez E, Cuerpos extraños en el área ORL: Rodríguez Domínguez FJ, Rodríguez Herrero D, editores. En: Manual de otorrinolaringología práctica para medico de atención primaria. 1 edición. Jaén: Editorial Formación Alcalá; 2009.p.766-70.
- V Gautam, J Phillips, H Bowmer, and M Reichl. Foreign body in the throat. J Accid Emerg Med. 1994
- Lue AJ1, Fang WD, Manolidis S. Use of plain radiography and computed tomography to identify fish bone foreign bodies. Otolaryngol Head Neck Surg. 2000 Oct;123(4):435-8.

URGENCIAS CERVICALES

MASAS CERVICALES

K.N. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia, J. Prada Pendolero.

INTRODUCCIÓN

Según su causa puede ser dolorosas o indoloras, cuando la causa es indolora los pacientes pueden acudir tarde a solicitar asistencia médica.

Causas de masas cervicales.

Causa infecciosa

- **VIH:** hay adenopatías generalizadas e indoloras, diagnóstico clínico y confirma con serología VIH.
- **Mononucleosis:** malestar general y faringitis, frecuente en adolescentes con múltiples ganglios cervicales, indoloros o moderadamente dolorosos, su diagnóstico se confirma con serología para virus de Epstein-Bar.
- **Infecciones bucofaringeas:** puede ser causa vírica o bacteriana, puede presentarse como una faringitis, infecciones del tracto respiratorio superior o infección dental, se palpa adenopatía aguda dolorosa al tacto de consistencia gomosa, múltiples ganglios linfáticos agrandados, su diagnóstico es clínico con cultivo de fauces.
- **Linfadenitis bacteriana primaria:** presenta una adenopatía aguda con dolor a la palpación.
- **Tuberculosis:** Tiene una adenopatía indolora, formando conglomerados inmóviles, a veces fluctuantes. Su diagnóstico es clínico y se confirma con Mantoux, cultivo y ELISA para tuberculosis.

Causas neoplásicas

- Ganglio local al tumor primario: bucofaríngeo, tiroideo, salival.
- Ganglios distales al tumor primario: linfomas, cánceres de próstata, mamas, colon o riñón, pulmón, digestivos altos.

Causas por trastornos congénitos.

- Quiste del conducto tirogloso.
- Quistes braquiales,
- Quiste sdermoides o sebáceos.

Otras causas

- Bocio difuso o nodular
- Tiroiditis subaguda
- Sialoadenitis o cálculos

En pacientes jóvenes las causas más comunes de masa/tumor cervical son:

- **Infección bacteriana primaria del ganglio linfático:** enfermedad por arañazo de gato, la linfadenitis tuberculosa, la toxoplasmosis y las actinomicosis
- **Adenitis reactiva.**
- **Infecciones sistémicas:** mononucleosis, tuberculosis, VIH.
- **Otras causas:** pueden ser los trastornos congénitos y son de larga evolución: quiste del

conducto tirogloso, quistes braquiales, dermoides o sebáceos.

DIAGNÓSTICO

Es clínico.

Características de las masas cervicales

- **Infecciosas:**
 - Inicio agudo
 - Dolor a la palpación, calor, rubor, disminución movilidad cervical
 - Asimétricos. Empastamiento cervical
- **Tumorales:**
 - Inicio insidioso en ocasiones asociado a clínica ORL (disfonía, disnea, disfagia, odinofagia)
 - Duros
 - No dolorosos
 - Fijos a tejidos adyacentes

TRATAMIENTO

Medidas generales si estabilidad hemodinámica.

Dependerá de múltiples factores como del tipo y lugar donde se localice.

Interconsulta con ORL

BIBLIOGRAFÍA

- https://www.msmanuals.com/es/professional/trastornos-otorrinolaringol%C3%B3gicos/abordaje-del-paciente-con-s%C3%ADntomas-nasales-y-far%C3%ADngeos/masa-cervical#v946067_es

URGENCIAS CERVICALES

PATOLOGÍA DE GLÁNDULAS

SALIVARES

K.N. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia, J. Prada Pendolero.

Sialolitiasis

Introducción

Obstrucción en conducto de drenaje de glándula submaxilar o parótida por cálculo intraluminal.

Diagnóstico

Inspección: Tumefacción glandular brusca, dolorosa. Palpación: Bidigital por dentro y fuera de la boca.

Tratamiento En Urgencias

- Sialogogos (limón)
- Amoxicilina/Ac. Clavulánico 875/125mg 1 cada 8 horas 7 días
- AINEs

Sialoadenitis (submaxilitis/parotiditis)

Introducción

Patología inflamatoria de glándulas salivares mayores. Vírica (Papovavirus, CMV) o bacteriana (Estafilococo, Neumococo, Anaerobios).

Diagnóstico

- Vírica: Malestar general, inflamación glandular bilateral, exudado no purulento por conducto.
- Bacteriana: Dolor, trismus, tumefacción y enrojecimiento unilateral, secreción purulenta por conducto.

Tratamiento En Urgencias

- Vírica: Sintomático, hidratación.
- Bacteriana: Amoxicilina/Ac. Clavulánico 875/125mg 1 cada 8 horas 7 días. AINEs.
- Revisión en consultas externas ORL.

Bibliografía

- Cummings C. Cummings otolaryngology head & neck surgery. Philadelphia, Pa: Elsevier Mosby. 2017.

FRACTURAS NASALES

Luz López Flórez, Cesáreo López Rodríguez, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Los traumatismos nasales constituyen un alto porcentaje de las urgencias, siendo las fracturas nasales las más frecuentes entre todas las fracturas de la cara y representando el 30-40 % de todas las fracturas óseas, lo que nos obliga a tener un conocimiento preciso del diagnóstico, manejo y complicaciones de las mismas.

Predominan en varones jóvenes salvo en la tercera edad donde existe una incidencia parecida. Las causas más frecuentes son las agresiones, los accidentes de tráfico y deportivos así como los traumatismos accidentales como caídas y golpes.

La proyección de la nariz sobre el plano coronal del resto de la cara hace que sea una estructura especialmente susceptible a recibir traumatismos aislados en el adulto, mientras que en la edad pediátrica la estructura más proyectada es la frente confiriendo cierta protección a la nariz.

Clasificación

En la literatura existen múltiples sistemas de clasificación de fracturas nasales. Una de las más conocidas es la clasificación de Rohrich (Tabla 1), aunque en la práctica clínica no se suele usar ningún sistema de clasificación ya que el manejo y tratamiento urgente no varía entre las fracturas más simples y las fracturas más complejas suelen conllevar lesiones más extensas que sobrepasan los límites de la nariz y minimizan su importancia.

Clasificación de Rohrich y Adams

I	Fractura simple unilateral.
II	Fractura simple bilateral.
III	Fractura conminuta. a) Unilateral b) Bilateral c) Frontal
IV	Fractura compleja (huesos nasales y septo). a) Hematoma septal asociado. b) Laceraciones nasales.
V	Fracturas naso-orbita-etmoidales.

Tabala 1

Anamnesis

Debe incluir:

- Edad. Anticoagulación. Antiagregación. Riesgo hemorrágico.
- Mecanismo y fuerza de la lesión.
- Pérdida de consciencia:
 - Si positiva: protocolo de traumatismo craneoencefálico (valorar TAC craneal).
- Síntomas acompañantes.
- Insuficiencia respiratoria nasal.
- Deformidades nasales previas.
- Pedir fotos (DNI, carnet de conducir) para comparar.

Exploración física básica

- Inspección:** cutánea (heridas, laceraciones, abrasiones), laterorrinia, edema, equimosis o hematomas infraorbitarios.

- **Palpación:** crepitación de huesos, hundimientos o escalones óseos.
Ha de ser sistemática: desde la inserción de los huesos propios al frontal bajando por su inserción al maxilar y volver a subir por la línea media (para mejorar la palpación humedecer las yemas de los dedos).
 - No olvidar zonas adyacentes: contorno de fosas nasales, arcos ciliares, malares y cigomáticos.
- **Rinoscopia anterior:** lesión de mucosas, desviación septal y hematoma septal.

Pruebas complementarias

- **Radiografía de huesos propios:** se desaconseja la práctica sistemática debido a su valor limitado. Solo para dejar constancia gráfica en caso de agresión o accidente.
- **TAC craneofacial:** en traumatismos severos con sospecha de afectación de otros huesos.

TRATAMIENTO

a. Menos de 4-5 horas tras traumatismo (no existe aún edema que dificulte la exploración): reducción cerrada inmediata.

- Infiltración con anestesia local (por ejemplo, Lidocaína 1% + Adrenalina) en nervios infraorbitarios. Un método práctico es administrar el anestésico por debajo del labio superior para alcanzar la fosa canina, así se pretende evitar los pinchazos innecesarios en el tejido cutáneo de la cara. Algunos autores recomiendan anestesiarse también la región de la raíz nasal con el fin de bloquear los nervios infratrocleares.
- Lentinas con vasoconstrictor y anestésico tópico en ambas fosas nasales.
- Instrumentos diseñados: fórceps de Asch y Walsham, elevador de Boies, etc o simplemente emplear el mango de un bisturí o una pinza Kocher. Medir externamente la longitud del instrumento necesaria para alcanzar el hueso propio hundido para no lesionar otras estructuras, introducirlo en la fosa nasal del lado hundido y realizar un movimiento conjunto de elevación de hueso propio hundido con medialización del hueso contralateral.
- Tras reducción: férula nasal durante 1 semana.

b. Más de 4-5 horas tras traumatismo (existe importante edema que puede enmascarar fracturas): revaloración en 48-72 horas con reducción cerrada de forma diferida si procede (no se compromete el resultado hasta 2 semanas tras el traumatismo).

c. Fracturas con afectación septal y fractura conminuta: fijación interna con gasa de borde o tapones tipo Merocel® en cada fosa nasal para obtener un efecto de soporte mecánico evitando sinequias y retirada en 3 días.

d. Reducción abierta: en quirófano bajo anestesia general.

e. En todos los casos:

- Limpieza cutánea y sutura de las lesiones si procede.
- Limpieza endonasal con aspirado de coágulos en caso de presencia.
- Frío local intermitente durante las primeras 48 horas.
- Antiinflamatorios y analgésicos.
- Revisión a los 6 meses: valorar septo/rinoplastia.

Complicaciones

a. Epistaxis

- Autolimitada: lavados nasales con suero fisiológico varias veces al día durante 1 semana.
- Leve persistente o recurrente: sustancias hemostáticas como Espongostan® o Surgicel®.
- Casos incoercibles: taponamiento completo de la fosa con Merocel® y retirada en 3 días.

b. Hematoma septal: drenaje, taponamiento nasal, cobertura antibiótica y reevaluación en 48 horas con nuevo drenaje si persiste.

Atención

- Ante cualquier traumatismo nasal:
 - Descartar hematoma septal.
 - Si pérdida de consciencia: necesidad de protocolo TCE y valorar TAC craneal.

BIBLIOGRAFÍA

- Chegar BE, Tatum SA. Nasal fractures. In: Flint PW, Haughey BH, Lund V, et al, eds. Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015:chap 33.
- Rohrich RJ, Adams WP Jr. Nasal fracture management: minimizing secondary nasal deformities. Plast Reconstr Surg. 2000 Aug;106(2):266-73. Review.
- Perkins SW, Dayan SH. Management of nasal trauma. Aesthetic Plast Surg. 2002 Nov;26 Suppl 1:S3.
- Malaty J. Facial and skull fractures. In: Eiff MP, Hatch R, eds. Fracture Management for Primary Care, Updated Edition. 3rd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2018:chap 17.

URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN ORL

Ignacio Alvarez Alvarez.

EPISTAXIS

La epistaxis es un problema frecuente, generalmente sin gravedad, ya que en los niños habitualmente la causa es local, y muy excepcionalmente constituye un síntoma de enfermedad sistémica.

La mayoría de las veces la ocasiona una inflamación local, infecciosa o alérgica y/o un microtraumatismo autoproducido por rascado o manipulación. Sin embargo, debe tenerse siempre en consideración, sobre todo en las repetidas, la posibilidad de que la epistaxis sea una manifestación de alguna enfermedad más grave: hipertensión arterial, discrasia sanguínea, hepatopatía, tumor.

La exploración es sencilla: una rinoscopia anterior nos mostrará, en la mayoría de las ocasiones, un punto hemorrágico en el área septal inferior. En estos casos la mejor opción es una **cauterización química** con una **barrita de Nitrato de Plata**. Si el punto sangrante no es visible podemos intentar controlarlo comprimiendo las alas nasales, introduciendo una bola de algodón con agua oxigenada o una esponja hemostática (Merocel y similares). Solo en casos excepcionales tendremos que recurrir a un neumotaponamiento con sonda de doble balón, a un taponamiento posterior clásico, a una embolización o a una cirugía de urgencia, pero todas esas opciones deben estar disponibles antes de que el sangrado comprometa hemodinámicamente al paciente. En estos casos la estabilización de las constantes, el control de factores favorecedores del sangrado y la evaluación conjunta con el especialista correspondiente son obligados.

CUERPOS EXTRAÑOS

Ante la sospecha de un cuerpo extraño en cualquier localización ORL se debe impedir la ingesta de alimentos o líquidos hasta conseguir la extracción, por si fuera necesaria una exploración quirúrgica. A continuación evaluar el sitio donde está alojado para saber si será necesaria una extracción bajo sedación o anestesia, teniendo siempre preparado el instrumental necesario para la extracción en esa primera exploración. La exploración en la consulta debe hacerse en posición sentada, nunca en decúbito; en los niños pequeños recurriremos a los padres o algún ayudante para mantenerlos sentados en la posición más erguida posible.

CUERPOS EXTRAÑOS EN EL OÍDO

Habitualmente la introducción ocurre durante el juego y no es excepcional que haya en ambos oídos o en oído y nariz, por lo que la exploración ha de ser completa. Suele tratarse de objetos inertes de cualquier composición. Los más **peligrosos** son las **pilas de botón**, por el riesgo de quemadura química. En el caso de que se trate de un insecto, la primera actuación ha de ser inmovilizarlo instilando alcohol en el conducto.

Generalmente es un adulto quien ha observado al niño introducirse el cuerpo extraño, pero otras veces es el propio niño el que lo dice; a veces es un hallazgo casual en una otoscopia por otro motivo y con poca frecuencia son los signos inflamatorios (dolor, edema, otorrea) los que nos llevan al diagnóstico.

Haremos una otoscopia teniendo a mano el instrumental necesario: aspirador de conducto, asa fría, ganchito, pinzas. La extracción con pinzas debe reservarse para alguien experimentado ya que de no conseguir atrapar el objeto en el primer intento, este migrará a una posición más distal

pudiendo lesionar el tímpano e impidiendo ya la evacuación sin anestesia.

Completada la extracción reexplorar el oído para comprobar el estado del mismo y la posible existencia de heridas, lesiones timpánicas o infección, y en su caso prescribir el tratamiento oportuno o remitir al especialista.

NASALES

Introducción

También aquí suele haber sido observado por algún adulto, pero no es excepcional el diagnóstico por un cuadro de rinorrea fétida y congestión nasal uni o bilateral. Cuerpos extraños no detectados pueden ser diagnosticados años después, generalmente en la edad adulta, como rinolitos debido a la precipitación de sales de Ca^{2+} . Una vez más las pilas de botón son las más problemáticas porque el ambiente húmedo hace que se degrade la carcasa metálica con extravasación de ácidos altamente tóxicos y abrasivos.

Diagnóstico

El diagnóstico suele ser sencillo.

- Por rinoscopia anterior o endoscopia nasal.
- Radiografía. Para objetos metálicos puede ser útil la radiología simple y solo en casos de alta sospecha sin visualización segura podría optarse por una TAC y/o una exploración endoscópica bajo sedación o anestesia.

Tratamiento

Una vez localizado el objeto se elegirá el instrumental en función de las características del mismo:

- aspirador.
- asa de alambre.
- ganchito de oído o pinzas que serán la última opción, y solo para personal entrenado, por el riesgo de introducir más e incluso desplazarlo a la rinofaringe con riesgo de broncospiración. Debemos, además descartar la presencia de algún otro objeto uni o contralateral o en los oídos, y si hay ya signos infecciosos prescribir un tratamiento antibiótico oral o tópico intranasal.

CUERPO EXTRAÑO EN LA VIA AERODIGESTIVA

La forma del objeto ingerido es determinante para el sitio de impactación

Así, cuerpos punzantes y ligeros como espinas de pescado o esquivras afiladas suelen enclavarse en las paredes faríngeas, casi siempre a nivel de las amígdalas o la base de la lengua, mientras que objetos más pesados o de contorno liso suelen alojarse en la vía aérea. Los punzantes tienen el riesgo de perforar la mucosa e incluso migrar a planos profundos con el riesgo de graves complicaciones infecciosas o vasculares.

La anamnesis no siempre es esclarecedora, sobre todo en los niños pequeños, porque el adulto que lo haya presenciado lo contará como que el niño “se ha tragado” algo. Es muy importante preguntar si ha habido en algún momento tos, disnea o disfonía, que nos orientarán hacia la laringe o la vía aérea inferior, mientras que la disfagia e hipersalivación harán más probable una impactación hipofaríngea o esofágica. La naturaleza del cuerpo extraño también es determinante en cuanto a maniobras diagnósticas y posibilidad de complicaciones. Los vegetales, como legumbres semillas, etc tienen una especial gravedad y deben ser manejados con la máxima prioridad porque por su contorno liso suelen migrar hasta la vía aérea, y por su tendencia a

hidratarse aumentando de tamaño, y la intensa reacción inflamatoria que provocan pueden desencadenar en poco tiempo complicaciones obstructivas graves. Aquí son mejor tolerados los inertes como monedas, bolas de plástico, etc, que pueden ser, además, localizados por radiología simple.

Un cuerpo extraño no sospechado puede estar en el origen de neumonías o abscesos de repetición en el cuello o el tórax o, incluso, simular un cuadro de asma o bronquitis de repetición.

Para el diagnóstico es decisiva la edad y grado de madurez del niño: salvo para cuerpos extraños en la orofaringe, que pueden ser vistos y extraídos en la consulta, en los niños más pequeños, o en aquellos que a cualquier edad no colaboren para la exploración, puede ser necesaria la radiología simple o la TAC y una exploración endoscópica flexible o rígida (rinofibrolaringoscopia, esofagoscopia, broncoscopia) o directa (faringo-larngo-esofagoscopia directas) bajo sedación o anestesia general, lo que, en el caso de impactación en la vía aérea superior, puede requerir la realización de una traqueotomía.

COMPLICACIONES DE LAS INFECCIONES ORL MÁS FRECUENTES EN NIÑOS

COMPLICACIONES DE RINOSINUSITIS

Poco frecuentes, pero potencialmente graves porque comprometen al ojo y/o al SNC.

Para su diagnóstico son importantes la anamnesis, buscando antecedentes de rinosinusitis y la exploración incluyendo la endoscopia nasal y la radiología: TAC y RM.

Las más frecuentes son las orbitarias, celulitis o abscesos, que se manifiestan por edema palpebral, dolor y proptosis, con afectación visual en los casos más graves. Habitualmente unilateral con origen en los senos etmoidales. Si no hay afectación visual o colección purulenta el manejo es conservador, con ingreso hospitalario para terapia antimicrobiana intensiva y control estrecho de la evolución. Los casos más graves se tratan de entrada, o tras una evolución desfavorable, con cirugía endoscópica.

Otra rara, pero grave complicación, es la trombosis del seno cavernoso, por migración retrógrada de la infección desde las venas oftálmicas. En este caso la clínica será también de edema palpebral, proptosis y disminución de la agudeza visual, incluso amaurosis, muchas veces bilateral, junto con síntomas y signos meníngeos.

Para el manejo de estas complicaciones contaremos con el oftalmólogo, que debe hacer un estrecho seguimiento de la visión, y con el neurólogo o el neurocirujano si hay afectación del SNC.

ABSCESO PERIAMIGDALINO

Introducción

Es una colección purulenta retroamigdalina secundaria a una amigdalitis. Suele ser polimicrobiana, pudiendo aislar estreptococos, estafilococos y anaerobios entre otros.

Diagnóstico

Es clínico. Se presenta como un abombamiento del paladar blando y desplazamiento anteromedial de la amígdala. La clínica consiste en disfagia, dolor, fiebre y trismus. Leucocitosis y elevación de la PCR / VSG. En caso de duda podemos recurrir a la ecografía o la TC.

Tratamiento

- **Punción** o incisión evacuadora.

- **Ingreso** para vigilancia y **antibioterapia intravenosa** de amplio espectro y tratamiento sintomático con exploración diaria hasta resolución.
- **Amigdalectomía:** mejor diferida para evitar complicaciones como hemorragia o sepsis. Se debe hacer en casos recidivantes o si hay amigdalitis crónica o de repetición.

ABSCESO RETROFARÍNGEO

Introducción

Colección purulenta, polimicrobiana, entre la pared posterior de la faringe y la fascia prevertebral. Más frecuente en lactantes y niños pequeños.

Diagnóstico

Es clínico. En la exploración encontraremos un abombamiento de la pared posterior de la orofaringe, con fiebre. La técnica más valiosa para confirmación y conocer la extensión es la TC. También la radiografía simple, ecografía o RM pueden ser de ayuda.

Tratamiento

El tratamiento será hospitalario: sin compromiso de la vía aérea antibioterapia intravenosa de amplio espectro, analgésicos y corticoides. Si no evoluciona favorablemente o aparece disnea habrá que optar por la cirugía.

ADENITIS CERVICAL

Inflamación de ganglios linfáticos cervicales con foco infeccioso en área ORL. Suele afectar a los ganglios yugulodigástricos, uní o bilaterales, casi siempre por estafilococos y menos por estreptococos y otros. El tratamiento consiste en un antibiótico oral por 10 días y seguimiento evolutivo. Si no hay resolución en 3 semanas hay que hacer una ecografía y una punción para diagnóstico microbiológico o anatomopatológico, como primeros pasos para esclarecer su origen. Por tanto, una vez pautado el tratamiento dejar pedida una cita con ORL en ese plazo.

COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE LA AMIGDALECTOMÍA

La amigdalectomía es una de las cirugías más frecuentemente practicadas a cualquier edad, pero sobre todo en los niños. Aun actualmente provoca complicaciones graves, con una mortalidad estimada de 1: 15.000. Las más frecuentes son las hemorragias en cualquier momento después de la cirugía, pero con mayor frecuencia en las primeras 24 horas (razón por la que habitualmente la intervención se realiza con ingreso) y hasta varias semanas después, con un pico de incidencia en torno al 10º día por desprendimiento de las placas de fibrina que recubren el lecho quirúrgico. Cualquier hemorragia debe ser considerada de riesgo, debiendo explorarse al niño y ordenando el ingreso si no se aprecia sangrado activo, para observación. Si hay sangrado continuo debe ser revisado quirúrgicamente bajo anestesia general, por tanto es muy importante desde el primer contacto dejar en ayunas con una vía venosa.

COMPLICACIONES DE LA ADENOIDECTOMÍA

También aquí la hemorragia es la más frecuente, que casi siempre requiere revisión quirúrgica pues la causa suele ser una extirpación incompleta que hay que totalizar.

El Síndrome de Grisel o subluxación rotatoria atloaxoidea, lo provoca una técnica quirúrgica inadecuada y es especialmente frecuente en niños con Síndrome de Down. Se manifiesta por

tortícolis con limitación de la movilidad del cuello. El diagnóstico se confirma con una radiografía simple de columna cervical y como tratamiento suele bastar el reposo con un collarín cervical.

TUBOS DE DRENAJE O DE VENTILACIÓN

Ampliamente utilizados en niños de cualquier edad para tratar diferentes tipos de otitis medias. Su finalidad es mantener una miringotomía (perforación timpánica) abierta el tiempo necesario para resolver cualquier forma de otitis, principalmente la otitis media serosa, causada por un mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio. Con ellos mantenemos una ventilación del oído medio evitando que el bloqueo de la trompa mantenga a éste en presión negativa.

Existen muchos tipos de tubos, son de fácil colocación para cualquier cirujano otológico y muy bien tolerados en la mayoría de casos. Sin embargo, en ocasiones dan problemas, casi siempre derivados de un deficiente cuidado postoperatorio, siendo la entrada de agua uno de los principales mecanismos de infección; esta se manifestará por una otorrea purulenta y menos frecuentemente por una otalgia. La consecuencia puede ser la obstrucción del tubo, que perderá su funcionalidad, o la expulsión del mismo antes de haberse resuelto la otitis.

Es por esto que debe tratarse precozmente cualquier otorrea en un oído con un tubo de ventilación, bien con gotas antibióticas, bien con un antibiótico oral de los que utilizamos para las otitis medias, ya que los patógenos suelen ser los mismos, aunque también puede haber *Pseudomonas* y *Candidas*.

Pautado el tratamiento es recomendable remitir en un plazo breve a ORL, por si fuera necesaria una otomicroscopia para repermeabilizarlo, o la retirada del mismo si la infección no cede.

MASTOIDITIS AGUDA

Pese a que el uso de antibióticos en la otitis media ha reducido drásticamente su incidencia, sigue siendo la complicación más frecuente de esta infección en los niños, sobre todo antes de los 3 años.

Es, además, el estadio intermedio hacia graves complicaciones intracraneales como meningoencefalitis, abscesos cerebrales, trombosis del seno cavernoso y otras, por lo que resulta crítico sospecharla y tratarla de forma enérgica y rápida, ya que las demoras diagnósticas suelen ser la causa de dichas complicaciones.

El patógeno más habitual es el neumococo, seguido del estreptococo betahemolítico, *Haemophilus* y *Staph. Aureus*, *Pseudomonas* y no es infrecuente la implicación de cepas resistentes a antibióticos. Es más frecuente en otitis medias no tratadas o con tratamientos incompletos.

Típicamente se manifiesta como una otitis media, actual o reciente, con afectación del estado general, que vuelve a presentar dolor, fiebre y empastamiento retroauricular. En la otoscopia podremos apreciar una otorrea, pero hay casos de mastoiditis larvada o abortada por el uso de antibióticos, en los que el tímpano estará íntegro. La analítica casi invariablemente mostrará una leucocitosis y elevación de la VSG.

Existe una forma bilateral, típica en recién nacidos afectados por otras patologías como malformaciones, inmunosupresión, etc.

El diagnóstico clínico y analítico se completará con estudios de imagen, TC inicialmente y RM en casos graves o con sospecha de complicaciones intracraneales.

El tratamiento inicial es empírico y conservador, con antibióticos de amplio espectro que pasen la BHE, siendo de elección las cefalosporinas de 3ª generación. Antes debe obtenerse una muestra para cultivo, que nos ayudará a ajustar el tratamiento en los días siguientes si la evolución no es satisfactoria. En los casos con tímpano íntegro debe hacerse una miringotomía evacuadora que

permitirá, además, la toma de una muestra bacteriológica y la colocación de un tubo de ventilación, lo que habitualmente acelera la resolución. En los casos más resistentes o complicados, aun hoy se realiza una intervención quirúrgica, la mastoidectomía, que constituía la base del tratamiento hasta la llegada de estos modernos antibióticos.

La prevención es muy importante, tratando adecuadamente cualquier forma de otitis media, y muy especialmente aquellas formas crónicas, persistentes o recidivantes, que están en el origen de muchas de las mastoiditis agudas actualmente.

PARÁLISIS FACIAL

Introducción

La mayoría de las veces idiopática, la llamada parálisis de Bell, de probable origen inmunoinflamatorio, producida por virus herpes y otros, o a reacciones de autoinmunidad.

La parálisis congénita puede ser embriopática o traumática en partos difíciles o instrumentados.

Otras son traumáticas en el contexto de cualquier traumatismo craneofacial, incluidas las yatrogénicas en cirugía otológica o cervicofacial.

Diagnóstico

- **Exploración:** hay que observar y si se puede, estimular la motilidad facial, mejor en posición sentada para observar el efecto de la gravedad, completada con una otoscopia y una exploración de la región parotídea.
En niños mayores puede hacerse una exploración reglada de la motilidad facial, junto con la otoscopia, inspección y palpación cervicofacial y una audiometría tonal; en los más pequeños tendremos que basar el diagnóstico en la observación pasiva, en el reflejo de succión, el llanto o la risa.
- **Exploraciones complementarias:** En casos dudosos pueden ser útiles la TAC y la RMN, así como el análisis audiológico que, en los niños pequeños debe comenzar por una timpanometría, y si hay sospecha de afectación auditiva complementar con PETAC.

Tratamiento

En la parálisis idiopática deben usarse corticoides orales, pese a que la evidencia científica sobre su utilidad no está totalmente asentada. En parálisis secundarias a otras dolencias, además de los corticoides habrá que hacer el tratamiento específico, médico o quirúrgico que esté indicado. El caso más frecuente es la parálisis secundaria a una otitis media, que requerirá un tratamiento antibiótico, o las traumáticas y yatrogénicas en cirugía del oído que suelen precisar revisión quirúrgica.

En todo caso debe prestarse atención al cuidado del ojo afectado para evitar complicaciones por desecación, la más frecuente la queratitis. Cremas hidratantes de uso oftálmico y lágrimas artificiales, junto con oclusión nocturna, suelen ser suficientes. En casos más complejos o de larga duración debemos contar con la ayuda del oftalmólogo.

El pronóstico es bueno en la parálisis idiopática, recuperando la función antes de un mes la mayoría de los casos. Son de peor pronóstico las completas o las que no muestren signos de recuperación en las tres primeras semanas.

Se dan recidivas uní o bilaterales en un 10% de los casos. Las unilaterales deben plantearnos el diagnóstico diferencial con un tumor que comprometa al nervio en cualquier punto de su trayecto intra y extracraneal.

BIBLIOGRAFÍA

- Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, 2ª edición, Ed Proyectos médicos. Madrid 2008.
- Tratado de ORL Pediátrica, 1ª edición, Ed Gráficas Alzamora, Girona 2000.
- Urgencias ORL. Ignacio Alvarez Alvarez. Urgencias de 0 a 100 años. J. Navarro Campoamor. Ed. Panamericana Madrid 2017.
- Infecciones en ORL. I Alvarez Alvarez, JP Rodrigo Tapia, J Rodriguez Asensio, M G. Caamaño. Patología Infecciosa en Atención Primaria.ed . J. Navarro Campoamor, Servicio de Salud del Principado de Asturias 2000.

MANEJO DEL PACIENTE PORTADOR DE TRAQUEOSTOMÍA EN URGENCIAS

Carles Heredia Llinàs, Fernanda Rodríguez Hott, Alejandro Löwy Benoliel.

¡RECUERDA!

- El diagnóstico de las Urgencias relacionadas con el uso de traqueostoma se diagnostican mediante ANAMNESIS y EXPLORACIÓN.
- La prioridad en todo momento debe ser MANTENER LA VÍA AÉREA.
- Muchos motivos de consulta pueden prevenirse mediante CUIDADOS EXQUISITOS, INFORMACIÓN e HIGIENE.

INTRODUCCIÓN

La traqueostomía o traqueotomía es una intervención quirúrgica que consiste en abrir una comunicación directa entre la pared anterior de la tráquea y la piel del cuello, creando una vía aérea artificial; este orificio recibe el nombre de “traqueostoma”. Una vez creado, el traqueostoma tiende a cerrarse de manera espontánea, por lo que es necesario el uso de una cánula (que puede estar hecha de diversos materiales) para estabilizarlo, facilitar la limpieza y maximizar la comodidad del paciente y del personal sanitario.

El principal objetivo de la traqueostomía es facilitar una vía aérea segura. Existen varias indicaciones para realizar este procedimiento, como el facilitar una vía para ventilación mecánica prolongada, crear una vía de ventilación en caso de obstrucción o mal manejo de secreciones o riesgo de aspiración.

Según el paciente y la indicación, la necesidad de la traqueostomía será permanente o temporal. En cualquier caso, un paciente portador de traqueostoma requiere unos cuidados particulares, y se enfrenta a una serie de riesgos de complicaciones que pueden llevarle a consultar en Urgencias.

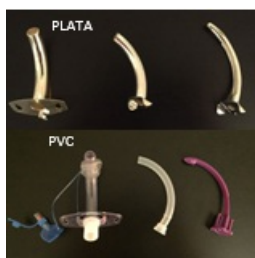
Cánulas de traqueostomía

La cánula es un tubo que se introduce en la tráquea a través del traqueostoma y lo mantiene permeable. Según el material, distinguimos entre cánulas de PVC (compatibles con sistemas de ventilación mecánica), de plata o de silicona.

Las cánulas que se utilizan inicialmente tras la realización de una traqueostomía son siempre de PVC. Existen dos tipos principales de modelos: con balón o pneumotaponamiento, que consiste en un manguito hinchable situado abrazando el extremo distal del tubo que protege la tráquea de aspiraciones; o sin balón.

Las cánulas de PVC y de plata constan habitualmente de dos componentes: un tubo endotraqueal propiamente dicho, y un “macho” o cánula interna, que tiene un calibre ligeramente inferior al de la cánula y se coloca en su interior. En caso de obstrucción o suciedad, el cambio únicamente del macho permite restituir la vía aérea sin necesidad de extraer la cánula en su totalidad. Existe también un tercer componente, la guía o fiador, que, al igual que el macho, se coloca en el interior de la cánula, y, mediante una punta afinada y roma que sobresale por el extremo distal, facilita la correcta colocación en el interior de la tráquea. Solo se utiliza el fiador en los momentos de cambio de cánula. Las cánulas de silicona suelen estar formadas por un único componente.

Existen numerosos tipos de cánulas, adaptadas a pacientes con diversas necesidades. Los pacientes portadores de traqueostoma permanente pueden ser usuarios de cánulas fenestradas, que permiten hablar con ella puesta; filtros para humidificar el aire, etcétera.



DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URGENCIAS HABITUALES

Disnea y obstrucción

La obstrucción de la cánula o de la tráquea altera o impide el flujo ventilatorio, y es un motivo habitual de consulta en Urgencias. La causa más habitual de taponamiento es el acúmulo de secreciones, que se secan en contacto con el aire y forman un tapón; la incapacidad de humidificar el aire y la alteración en el flujo mucociliar que la traqueostomía produce predisponen a la formación de tapones de moco.

En algunos casos, este tapón puede estar formado por restos hemáticos (más frecuentes en el periodo posoperatorio inmediato, dado el riesgo de sangrado). También es necesario descartar la presencia de cuerpos extraños en la vía aérea.

- **Diagnóstico:** El paciente refiere disnea y sensación de oclusión en la vía aérea. En casos graves, la oclusión puede ser completa. Durante la exploración, se evidencia un flujo de aire a través de la cánula disminuido.
- **Tratamiento:** Debe retirarse el macho de la cánula y comprobar si está ocluido; si es así, debe colocarse un nuevo macho limpio. En caso de que la cánula sea de una pieza, o de que el macho no esté ocluido, debe retirarse la cánula y aspirar mediante una sonda a través del traqueostoma: es habitual notar la obstrucción como un tope de consistencia dura. Debe pedirse al paciente que expulse el tapón tosiendo, ayudando mediante la instilación directa de suero fisiológico o mucolítico (p.ej.: mesna) a través del traqueostoma (no más de 1cc de una vez) o su administración en aerosoles, y la aspiración. La expulsión del tapón resuelve el cuadro.

Ante la sospecha fundada de cuerpo extraño en la tráquea, es necesaria la valoración por un especialista en ORL.

Es importante tener en cuenta que un cuadro de disnea y obstrucción respiratoria puede no estar causado por un problema a nivel de tráquea o traqueostoma, por lo que exige un diagnóstico diferencial con procesos bronquiopulmonares (p.ej.: reagudización de EPOC, neumonía...).

Aspiración y disfagia

El paciente traqueostomizado presenta habitualmente problemas para la deglución tanto de sólidos como de líquidos. El uso de cánula dificulta o impide el ascenso de la laringe durante la deglución; además, el paciente traqueostomizado puede presentar otros factores que empeoren o condicionen disfagia (edad avanzada, enfermedades neurológicas, periodos largos de afagia...).

- **Diagnóstico:** El paciente refiere dificultad para deglutir sólidos o líquidos, con o sin

atragantamientos. Puede haber salida de alimentos por la cánula o el estoma. Puede haber signos y síntomas de complicación (neumonía broncoaspirativa).

- **Tratamiento:** Debe recomendarse una dieta con uso de espesantes, evitando dobles texturas y procurando masticar y tragar en un ambiente tranquilo y sin prisas, en sedestación y acercando el mentón al pecho en el momento de deglutir. Es conveniente mantener el balón deshinchado o usar una cánula sin él, puesto que dificulta la deglución. Sin embargo, mantener el balón hinchado evita el paso de alimentos a la vía aérea en caso de aspiración, y es conveniente usarlo si el paciente toma pequeños sorbos varias veces al día. En caso de imposibilidad para deglutir o evitar la aspiración, debe evitarse la alimentación oral y consultar con el especialista para estudio completo de deglución.

La mayoría de pacientes mejora en su deglución a medida que se acostumbra al traqueostoma. La principal complicación de este cuadro es la neumonía broncoaspirativa. En caso de diagnosticarse, deberá suspenderse la alimentación oral y establecer el tratamiento apropiado.

La fístula traqueoesofágica es un cuadro infrecuente pero grave que cursa con dolor cervical o retroesternal, especialmente durante la deglución, salida de alimentos por el estoma y broncoaspiración, y puede complicarse con una mediastinitis aguda. Sus causas, en relación con la traqueostomía, incluyen úlceras por decúbito causadas por la cánula, lesiones durante la cirugía, infecciones, pinzamiento entre cánula y sonda nasogástrica o lesión por cuerpos extraños o cáusticos. En caso de sospecha, debe referirse inmediatamente al especialista. Su tratamiento es quirúrgico.

Hemorragia

La hemorragia a través del traqueostoma es un motivo de consulta habitual. Las causas posibles son numerosas, y es necesario en un primer lugar determinar la gravedad de la hemorragia y su origen aparente. La mayoría de ocasiones, el sangrado tiene relación con la propia intervención, y se corresponde a un manchado leve de la herida. En pacientes intervenidos mucho tiempo atrás, el origen del sangrado suele ser una lesión en el estoma o la tráquea de aparición reciente. Hay que tener en cuenta que una hemorragia en la vía aerodigestiva superior o en el pulmón causarán habitualmente la salida de sangre a través de la cánula, ya sea por la caída de la misma por gravedad o impulsándola hacia la tráquea al toser. Siempre hay que tener presentes estos posibles orígenes, en los que el traqueostoma es un hecho incidental.

- **Diagnóstico:** El paciente refiere la salida de sangre o restos hemáticos a través de la cánula o el traqueostoma. Puede haber o no un antecedente de traumatismo o lesión por cuerpo extraño. El sangrado puede evidenciarse en el momento de la exploración, o que solo se encuentren restos hemáticos. Es necesario retirar la cánula e inspeccionar concienzudamente los bordes del traqueostoma y las paredes de la tráquea en busca de lesiones que justifiquen la hemorragia. También debe explorarse la vía aerodigestiva superior) en busca de epistaxis o sangrados a ese nivel, y valorar la posibilidad de sangrado de origen broncopulmonar. Con el balón hinchado, la salida de sangre a través de la cánula es sugestiva de hemorragia distal, y la salida alrededor de ella lo es de sangrado en vía superior o periestomal.
- **Tratamiento:** En caso de sangrado copioso, es necesario proteger la vía aérea colocando una cánula de PVC con balón e hincharlo, de tal manera que se evite la caída de sangre a la vía aérea inferior; acto seguido, contactar con el especialista y e intentar estabilizar al paciente si fuera necesario. Sangrados de escaso débito a través de pequeñas erosiones o lesiones benignas en traqueostoma (ver más adelante) pueden ser controlados aplicando nitrato de plata. Los restos hemáticos no justificados por la exploración del área pueden haberse originado a otro nivel. En caso de que persistan dudas sobre el origen de la

hemorragia, debe contactarse con el especialista para exploración más concienzuda (p.ej.: fibrolaringoscopia).

Lesiones periestomales

La exposición constante del traqueostoma y las paredes de la tráquea a manipulaciones y posibles factores lesivos condiciona un riesgo para la aparición de pequeñas lesiones cutáneas y mucosas, que suelen cursar con dolor, molestias, prurito, dificultad para el cambio de cánula y hemorragias leves.

- **Diagnóstico y tratamiento:** El paciente refiere alguno de los síntomas antes mencionados, o él mismo o un cuidador han visto una lesión de reciente aparición. Es necesario examinar a vista los bordes del estoma y la tráquea. Son lesiones frecuentes:
 - **Granuloma:** Crecimiento vegetante de aspecto rojizo y propenso al sangrado, no doloroso, especialmente en el borde inferior. Causado por la fricción de la cánula y la humedad. Se cauteriza con nitrato de plata, se aplica pomada antibiótica y se asegura que la cánula está bien fija y es del tamaño apropiado.
 - **Dermatitis:** Piel irritada, descamada, con prurito o dolor. Causada por la maceración debida al acúmulo de secreciones. Deben indicarse limpieza frecuente y sequedad.
 - **Infección:** Puede haber una sobreinfección del estoma o la herida. Inflamación intensa y dolorosa de la zona. Tratar, según gravedad, con antibiótico tópico+/-sistémico. Contactar con especialista si muy extensa.
 - **Úlcera por presión:** Debida a la cánula. Muy dolorosa, en piel o pared traqueal. Hay indicar cambios frecuentes de cánula y de posición, y limpieza de la zona. Puede usarse crema cicatrizante o antibacteriana para prevenir sobreinfección.

Pueden aparecer granulomas en la pared anterior de la tráquea, inferiormente al traqueostoma, debidas a la fricción por la cánula ("a punta de cánula"). La correcta exploración debe realizarse mediante espejito o fibroscopio.

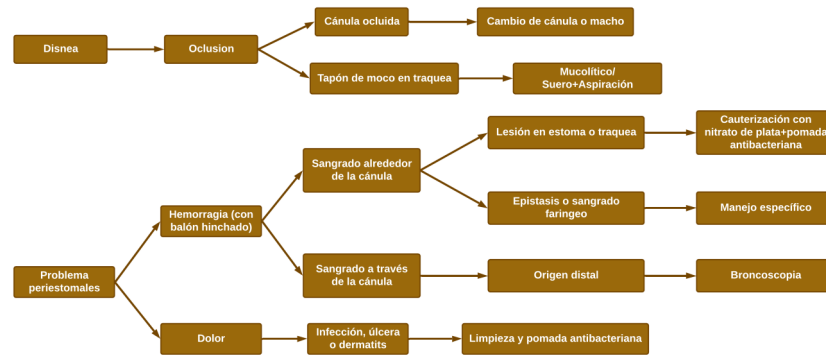
Ante la presencia de lesiones sospechosas de malignidad (especialmente en pacientes con historia de cáncer en cabeza y cuello), debe remitirse rápidamente al especialista.

Problemas en el manejo de la cánula

El cuidado del traqueostoma exige manejar de manera autónoma la cánula: conocer sus componentes y ser capaz de su cambio y limpieza. Son problemas habituales:

- **Estenosis:** Un periodo de 60-90 minutos sin cánula puede condicionar que el estoma empiece a cerrarse, causando estenosis. El tratamiento con radioterapia también puede condicionar estenosis. Debe procederse a la dilatación escalonada del estoma mediante cánulas de tamaño creciente, hasta poder colocar de del tamaño apropiado. En casos de que esto sea imposible, se colocará una cánula más pequeña. En ningún caso debe permanecer el estoma sin cánula.
- **Falsa vía:** Es posible crear, sobre todo si se realizan los cambios sin cuidado, una "falsa vía" en el traqueostoma: un espacio anatómico subcutáneo que se abre paso distalmente, siguiendo la posición de la tráquea, en fondo de saco y en el que se puede introducir la cánula. Es importante realizar los cambios visualizando la entrada a la tráquea, y comprobando siempre que haya buen paso de aire. En caso de que se sospeche la presencia de una falsa vía de gran tamaño, contactar con el especialista.
- **La cánula se mueve mucho o se sale:** Deben evitarse movimientos bruscos, y mantener la cánula bien atada en todo momento. Debe ajustarse el tamaño de la cánula al del cuello del

paciente y el de su traqueostoma.



BIBLIOGRAFÍA

- Libro virtual de formación en ORL. Madrid: Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Web SEORL.
- Soto Campos, J. y Acosta Bazaga, E. (2016). Manual de diagnóstico y terapéutica en neumología. Majadahonda, Madrid: Ergón.
- Caravaca García A. (2014) Manual de manejo de la traqueotomía para sanitarios y pacientes. Albacete: LiberLIBRO.com
- Dawson, D. (2014). Essential principles: tracheostomy care in the adult patient. Nursing in Critical Care, 19(2), pp.63-72.

FÁRMACOS DE USO EN ORL

Luis Alfredo Alonso Cuesta, Gerardo Jose Martin Siguenza, Juan Manuel Santos Escudero, María del Mar Bances Robles, Julio Tito Camino Acha.

DIAGNOSTICO	PRINCIPIOS ACTIVOS	Dosis	NOMBRE COMERCIAL
Tapón de cerumen	Gotas anticeruminosas	2-4 gotas cada 8h x 3 días	Anticerumen Liade Otocerumen gotas Taponoto
Otitis externa difusa	Amoxicilina/ Acido clavulánico	875/125mg: 1 cada 8h x 10 días	Augmentine 500/125mg Augmentine 875/125mg
	Ciprofloxacino gotas con sin corticoide	4 gotas cada 12 horas durante 7 días	Aceoto gotas. Aceoto Plus (ciprofloxacino/flucinolona) Baycip gotas Cetraxal gotas Cetraxal plus Ciflot gotas
	Fluocinolona, Polimixina b, Neomicina gotas	3-4 gotas cada 8 horas 7-10 días.	Synalar ótico gotas
	Dexametasona, Polimixina B, Trimetoprim gotas:	4 gotas/8h 7-10días	Otix gotas
	Dexametasona, Gentamicina gotas:	3 gotas cada 8horas 7-10 días	COLIRCUSÍ GENTAMICINA 3 mg/ml colirio en solución
Otitis externa circunscrita	Cloxacilina 500mg	1 cada 6 horas durante 7 días	ORBENIN Cáps. 500 mg
	Mupirocina pomada:	1 aplicación cada 8horas durante 7 días	Bactroban 20 mg/g pomada Plasmine20 mg/g pomada
	AINES: Ibuprofeno 600mg Dexketoprofeno 25mg Diclofenaco 50mg	1 comprimido cada 8h si dolor.	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg comprimido
Otomycosis	Alcohol 70º boricado a saturación más ácido acético al 2%	2 gotas cada 8h durante 15 días	Alcohol 70º boricado a saturación más ácido acético al 2%
	Beclometasona dipropionato / Clioquinol	2-3 gotas cada 8h, durante 7 días	Menaderm otológico
	Clotrimazol 10 mg/ml solución	2-3 veces/día	Canestén 10 mg/ml solución para pulverización cutánea
	AINES: Ibuprofeno 600mg Dexketoprofeno 25mg Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
Eccema del CAE	Metilprednisolona acetonato tópico:	1 aplicación cada 12horas durante 5 días	Lexema crema
Otitis media aguda no supurada	Amoxicilina 500mg.	1 cada 8horas durante 10 días	Clamoxyl
	Amoxicilina-acido clavulánico 500/125mg; 875/125mg:	1 cada 8horas durante 10días	Augmentine 500/125mg; Augmentine 875/125mg
	AINES: Ibuprofeno 600mg Dexketoprofeno 25mg Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
Otitis media crónica reagudizada	Ciprofloxacino gotas	2-4 gotas cada 12 horas durante 7 días	Aceoto gotas, Aceoto Plus (ciprofloxacino/flucinolona) Baycip gotas Cetraxal ótico Ciflot gotas
	Fluocinolona 0,25 mg + Neomicina 3,5 mg + Polimixina B gotas.	4-5 gotas cada 8 horas durante 6-7 días.	Synalar ótico

DIAGNOSTICO	PRINCIPIOS ACTIVOS	Dosis	NOMBRE COMERCIAL
	Ciprofloxacino 500 mg comprimidos	1 comprimido cada 12 horas durante 10 días	Cetraxal Baycip
Otitis seromucosa/ Ototubaritis	Oximetazolina hidrocloreto 0,5 mg/ml spray nasal.	2 pulverizaciones cada 6 horas durante 5-7 días.	Utabón Nebulicina
	Fenilefrina 0,5% spray nasal.	1-2 pulverizaciones cada 8 horas durante 5-7 días	Disneumon Pernal
	Fluocinolona 0,1 mg + Fenilefrina 1,25 mg + Neomicina 3,5 mg + Polimixina B.	4-5 gotas ó 2 pulverizaciones cada 8 horas durante 6-7 días.	Synalar nasal
	Cetirizina 5 mg + Pseudoefedrina 120 mg comprimidos.	1 comprimido cada 12 horas durante 5-7 días.	Stopcold
	Loratadina 5 mg + Pseudoefedrina 120 mg comprimidos.	1 comprimido vía oral cada 12 horas durante 5-7 días	Narine
	Furoato de fluticasona 27,5 mg/ml spray nasal.	2 pulverizaciones cada 24 horas 15-20 días	Avamys
	Mometasona furoato spray nasal.	:2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Nasonex
	Triamcinolona acetónido spray nasal.	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Nasacort
	Budesonida spray nasal	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Budesonida Aldo-Unión
	AINES: Ibuprofeno 600mg Dexketoprofeno 25mg Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
Vértigo periférico	Sulpiride 50 mg cápsulas.	1 cápsula cada 8 horas durante 7-10 días.	Sulpiride (Dogmatil)
	Betahistina comprimidos de 8 ó 16 mg.	1 comprimido cada 8 horas durante 15-20 días.	Serc 8, Serc 16.
	Diazepam comprimidos de 5 ó 10 mg:	1 comprimido cada 12 horas durante 10-15 días.	valium
	Lorazepam 0,25mg; 0,5mg; 1mg	1 comprimido sublingual cada 8h durante 10 -15 días.	Lorazepam
Síndrome de Menière	Betahistina (dihidrocloreto de betahistina)24	1cada 12 horas durante 10 días.	Serc24 mg comprimidos
Parálisis facial periférica	Deflazacort 30 mg comprimidos.	iniciar con 60mg 1 cada 24 h durante 5días 45mg 1 cada/24h durante 5días. 30mg 1 cada 24h durante 5días y 15mg 1 cada 24h durante 5 días luego suspender.	Zamene Dezacor
	Metilprednisolona 40 mg comprimidos	iniciar con 40 mg cada 24 horas y seguir una pauta descendente durante 7-10 días	Urbason
	Aciclovir 200 mg comprimidos.	1 comprimido cada 6 horas durante 7-10 días	Aciclovir
	Famciclovir 750 mg comprimidos.	1 comprimido cada 24 horas durante 7 días	Famciclovir
	Vitamina B12, B6, B1 comprimidos.	1 comprimido cada 8 horas durante 10-15 días	Hidroxitil
Disfonía Aguda	Deflazacort 30 mg comprimidos.	Iniciar con 30 mg cada 8 horas y seguir una pauta descendente durante 7-10 días.	Zamene Dezacor

DIAGNOSTICO	PRINCIPIOS ACTIVOS	Dosis	NOMBRE COMERCIAL
	Metilprednisolona 40 mg comprimidos.	iniciar con 40 mg cada 8 horas y seguir una pauta descendente durante 7-10 días	Urbason
	Reposo vocal y AINES: Ibuprofeno 600mg o Dexketoprofeno 25mg o Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
Laringitis aguda infecciosa	Reposo vocal y AINES: Ibuprofeno 600mg o Dexketoprofeno 25mg o Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor x 7 días	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
	Amoxicilina-ácido clavulánico	1 cada 8 horas durante 7 días	Augmentine 500/125mg Augmentine 875/125mg
Faringitis aguda	AINES: Ibuprofeno 600mg o Dexketoprofeno 25mg o Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
Amigdalitis Aguda	Amoxicilina-ácido clavulánico 500/125 mg ó 875/125mg oral.	1 cada 8 horas durante 7 -10 días	Augmentine
	Cefuroxima axetilo 250mg ó 500 mg comprimidos	1 comprimido 250 mg cada 12h durante 7 días. 1 comprimido 500mg cada 12h durante 7 días.	Zinnat 250mg ó 500mg comprimidos
	Cefditoreno 200 ó 400mg	1 comprimido cada 12 horas durante 10 días	Spectracef 200mg ó 400mg. Meiact 200mg ó 400mg.
	Clindamicina 300 mg cápsulas. Reposo, analgesia, antitérmicos e hidratación.	1 cápsula cada 8 horas durante 7- 10 días	Dalacin
Mononucleosis infecciosa			
	20 % sobreinfección bacteriana. Usar clindamicina 150 mg	1 cada/8 h durante 7 días oral.	Clindamicina
Sinusitis Aguda	Cetirizina 5 mg + Pseudoefedrina 120 mg comprimidos.	1 comprimido cada 12 horas durante 7-10 días	Stopcold
	Loratadina 5 mg + Pseudoefedrina 120 mg comprimidos	1 comprimido cada 12 horas durante 7-10 días	Narine
	Amoxicilina-ácido clavulánico 500/125 mg ó 875/125mg oral:	1 cada 8 horas durante 10 días	Augmentine
	Cefuroxima 500 mg comprimidos	1 comprimido cada 12 horas durante 7-10 días	Zinnat
	Cefditoreno pivoxilo 400 mg comprimidos	1 comprimido cada 24 horas durante 7 días	Meiact Spectracef
	Furoato de fluticasona 27,5 µg/dosis spray nasal	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Avamys
	Mometasona furoato 50 µg/dosis spray nasal	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Nasonex
	Triamcinolona acetónido 50 µg/dosis spray nasal	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Nasacort
	Budesonida nasal 100 µg/dosis spray nasal: 2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Budesonida Aldo-Union

DIAGNOSTICO	PRINCIPIOS ACTIVOS	Dosis	NOMBRE COMERCIAL
	AINES: Ibuprofeno 600mg o Dexketoprofeno 25mg o Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
Rinitis / Congestión nasal	Oximetazolina hidrocloreto 0,5 mg/ml spray nasal	2 pulverizaciones cada 6 horas durante 5-7 días	Utabón Nebulicina
	Fenilefrina 0,5% spray nasal	1-2 pulverizaciones cada 8 horas durante 5-7 días	Disneumon Pernal
	Furoato de fluticasona 27,5 µg/dosis spray nasal	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Avamys
	Mometasona furoato 50 µg/dosis spray nasal	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Nasonex
	Triamcinolona acetónido 50 µg/dosis spray nasal:	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Nasocort
	Budesonida nasal 100 µg/dosis spray nasal	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Budesonida Aldo-Union
	AINES: Ibuprofeno 600mg o Dexketoprofeno 25mg o Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
	Antihistaminicos: Cetirizina 10mg	1 cada 24hx 7 días.	ZYRTEC® ALERLISIN

BIBLIOGRAFÍA

- Ponencia Oficial del LXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial. 2011: Farmacología aplicada en Otorrinolaringología. Jesús Iniesta Turpín. Rafael Pérez Aguilera. Luis Amorós Rodríguez
- <http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-antibioticos-betalactamicos-S0213005X08000323>
- Guías rápidas para el manejo de los procesos otorrinolaringológicos en atención primaria 2012. Sociedad Andaluza de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial